

CƠ SỞ

Bài 1. Vai trò và nhu cầu của các chất dinh dưỡng

I. Năng lượng

- 1 Kcal = 4.184 Kilojun, là năng lượng cần thiết để làm nóng 1l nước lên 1 độ C
- 1g pro và 1g glucid cung cấp 4 Kcal, 1g lipid cung cấp 9 Kcal
- Cân đối Pro:Lipid:Glu = 12:18:70 tiến tới 14:20:66, Lipid k nên vượt quá 30% khẩu phần
- Tăng 1g thể trọng cần 8 Kcal. Người gầy khi đói mất Nitơ gấp 2l người béo

II. Trong chuyển hoá cơ bản

- Chỉ dùng để duy trì các chức năng: tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, duy trì thân nhiệt
- Đo: lúc mới ngủ dậy, chưa vận động, sau ăn 12-18h
- Thực nghiệm: năng lượng cho chuyển hoá CB: 1 Kcal/kg với nam và 0.9 với nữ
- Hiện nay dùng khái niệm "chuyển hoá lúc nghỉ" nhiều hơn

III. Trong hoạt động thể lực

- Hoạt động thể lực TB: cần 15-30% tổng nhu cầu năng lượng
- Cường độ cao có thể 10-15 lần năng lượng chuyển hoá lúc nghỉ

IV. Các chất sinh năng lượng

1. PROTEIN

a. Acid amin

- Người lớn 9 aa cần thiết, trẻ em 10 (thêm Arginin)
- Pro từ thức ăn động vật khá đầy đủ và cân đối aa, trong đó trứng và sữa được coi là "pro chuẩn"

b. Vai trò pro (5)

- Tạo hình
- Tham gia vận chuyển dinh dưỡng, kích thích ngon miệng
- Điều hoà hoạt động cơ thể (cấu thành hormon, enzym, kháng thể)
- Bảo vệ cơ thể, khử độc
- Cung cấp E (khi ăn k đủ Glu và Lipid)

- Bảo vệ cơ thể, khử độc
- Cung cấp E (khi ăn k đủ Glu và Lipid)

c. Nhu cầu Protein

- Khuyến nghị cho người lớn VN 1.25g/kg/ngày, trong đó 30-50% nguồn gốc đv
- Thiếu pro trường diễn → mỡ hoá gan, rối loạn nội tiết, MD, dễ nhiễm trùng
- Thừa → lipid

d. Nguồn protein

- Đậu tương (34%), đậu xanh, gà tây, chân giò lợn, thịt gà

2. LIPID

- No: butiric, caprylic, myristic, panmitic, stearic nguồn gốc đv
- K no: linoleic, arachidonic nguồn gốc tv

a. Vai trò lipid (4)

- Giống pro: tạo hình và điều hoà hoạt động cơ thể, cung cấp năng lượng
- Khác: chế biến thực phẩm

b. Nhu cầu lipid

- Tv 30-50% (4-10% khẩu phần), đv ≤ 60% (đảm bảo ≤ 10% năng lượng khẩu phần)

c. Nguồn lipid

- Đv: thịt lợn mỡ (37.3%), phomat, thịt ngỗng
- Tv: hạt dẻ (59%), hạt điều khô, hạt lạc

3. GLUCID

- 3 loại: đường đơn, đường đôi, đường đa phân tử
- K nên ăn nhiều glucid tinh chế

a. Vai trò glucid

- Giống pro và lipid: tạo hình và điều hoà hoạt động cơ thể, cung cấp năng lượng
- Khác: cung cấp chất xơ

b. Nguồn:

- Tv: ngũ cốc, đường mật, hoa quả, rau
- Đv: sữa

V. Các chất không sinh năng lượng

1. VITAMIN

a. Nhóm tan trong dầu

- Vận chuyển trong máu nhờ lipoprotein, thừa được tích lũy ở gan → biểu hiện thiếu thường xuất hiện muộn hơn so với vtm tan trong nước, nhưng dùng liều cao dễ ngộ độc

b. Nhóm tan trong nước

- Dễ bị biến tính dưới tác động vật lý
- Nhu cầu tăng theo nhu cầu năng lượng

2. CHẤT KHOÁNG

- Đa lượng: nhu cầu hàng ngày >100mg
- Vi lượng

3. NƯỚC

- 50-70% trọng lượng cơ thể
- Chức năng: dung môi hoà tan, môi trường phản ứng và điều nhiệt
- Nhu cầu: người lớn 1l/1000Kcal khẩu phần, trẻ em 1.5

	Chức năng	Nhu cầu	Thiếu	Thừa	Nguồn
Vtm A	-Thị giác -Cấu trúc da -Miễn dịch -Tạo máu -Tăng trưởng -Sinh sản -Chống lão hoá -Ngừa K	<1t: 375-400 tăng dần đến Người lớn 600 $\mu\text{g}/\text{day}$ Tăng cao ở gđ cho con bú, nhiễm trùng, phục hồi bệnh	Đầu tiên là quáng gà. Sau là da khô, rụng tóc, gãy móng, bội nhiễm hô hấp, mất hẳn thị giác	Nhiễm độc (viêm da, khớp, đau bắp thịt, rụng tóc, viêm gan), gây quái thai ở PNCT	- Đv (retinol): gan, lòng đỏ trứng, sữa, phomat -Tv (caroten): rau quả màu xanh đậm, vàng
Vtm D	-Tăng cốt hoá xương -Cân bằng calci nội mô -Điều hoà chức năng 1 số gen	-TB 5 $\mu\text{g}/\text{day}$ - 51-60t 10 $\mu\text{g}/\text{d}$ ->60t 15 $\mu\text{g}/\text{d}$ <i>Trẻ bú mẹ: 5-7,5 $\mu\text{g}/\text{ngày}$</i>	RL hấp thu Ca và P (cấp gây cơn Tenani, mạn gây còi xương, hồng răng, loãng xương)	-Giòn xương, lỏng động Ca, P vào thận, tim (sỏi thận) -Nhiễm độc (biếng ăn, nôn mửa, nhức đầu)	-Cá biển, thịt, trứng, nấm - Được tổng hợp dưới da với tác dụng của UV
Vtm E	- chống OXH - Ngừa K - Ngừa bệnh TM -Miễn dịch (lympho T) -Bảo quản TP (bơ, dầu ăn)	5-20mg/d Tăng ở PNCT CCB, Trẻ đẻ non			Các loại hạt

Vtm K	-Tổng hợp Prothrombin. -Có 3 dạng: K1 trong TP, K2 sản xuất ở ruột già, K3 thuốc tổng hợp	50-60 ug/d thay đổi vì lượng lớn đc tổng hợp ở ruột già	trẻ sơ sinh gây XH não-màng não		-Người BT ăn nhiều rau và hệ TH bình thường k cần bổ sung -max ở lá xanh
B1	-Chuyển hoá glucid và E -Dẫn truyền xung động TK	0.4mg/1000Kcal khẩu phần	Gây độc TK (Chán ăn, mệt, hốt hoảng, táo bón) Năng gây bệnh Berri berri	(những người nghiện rượu, chay thân hoặc nuôi ăn TM lâu ngày dễ thiếu)	Vỏ cám, mầm hạt ngũ cốc, thịt nạc, phủ tạng
B2	-Cân bằng dinh dưỡng -thành phần enzym -kích thích tăng trưởng, tái tạo TB -đảm bảo thị giác	cần 0.55/1000Kcal <i>mg</i>	Nhiệt môi, lưỡi, viêm da, môi mất		Có ở nhiều TP nhưng lượng k nhiều, tương tự B1
PP (niacin)	-TP enzym quan trọng -Bảo vệ da và nm	6.6mg/1000Kcal <i>Được lượng niacin = 6.6mg</i>			Thịt cá lạc đậu đỗ sữa trứng
B6	-CH pro và glucid -Dẫn truyền xung động TK	1,6mg/d với nữ. 2mg/d với nam Tăng khi ăn tăng Pro và PN dùng thuốc tránh thai	Mệt mỏi, dễ kt, trầm cảm, viêm da		Thịt gia cầm, cá, gan, khoai tây, chuối, rau muống
Folat	Tổng hợp AND, Hb, chuyển hoá pro	180ug/d với nữ, 200 với nam Tăng cao ở PNCT và TE	ở PNCT gây dị tật thai, ở trẻ gây thiếu máu HC to, chậm pt thể chất- tinh thần	Sử dụng nhiều Folat gây thiếu B12	Rau xanh, hoa quả, đậu đỗ
B12	Tương tự Folat, ngoài ra tạo Myelin	2 ug/d Tăng ở PNCT CCB BN cắt dạ dày phải tiêm bổ sung	Triệu chứng thần kinh		Động vật
Vtm C	-Chống OXH -Tạo collagen -KT hoạt động 1 số tuyến -Ngừa K (+VTM E) -Thải độc -Tăng hấp thu sắt	70-75mg/d Người nghiện thuốc lá 100-200	-Xuất huyết, chậm liền vết thương. -Nặng là bệnh Scorbut qua 3 gđ	-Tiêu chảy, buồn nôn, sỏi oxalat thận -Thiếu khi dùng đột ngột	Rau và hoa quả

	ở ruột non				
Sắt	-Tham gia tạo hem -Thành phần enzym	Nam 10mg, nữ 15mg PNCT CCB, kinh nguyệt x2			Hầu hết sắt trong khẩu phần là sắt k hem (rau quả, trứng, sữa) Sắt hem (thịt) dễ hấp thu hơn
Kẽm	-Tăng trưởng và sinh sản -Miễn dịch -Phát triển hệ TK	Nam 15mg, nữ 12mg Tăng ở PNCT CCB			Sữa mẹ, thịt, gan, hải sản
Iod	-TP tuyến giáp	150 ug/d Tăng ở PNCT CCB	Bướu cổ, phù niêm, giảm khả năng pt trí tuệ, tinh thần		Muối iod, hải sản
Can	-Ca và P cấu tạo nên xương và răng -hoạt động của tim -Đông máu	-người trưởng thành 700mg >50t=dậy thì=có thai CCB= 1000mg	Yếu cơ, tetani, loãng xương, còi xương	Sỏi thận Giảm khả năng hấp thu sắt, kẽm	Ca/P min >0.8, tốt nhất là 1-1.5

Bài 2. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của các nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật và thực vật

Nguồn gốc động vật

1. Thịt

Thành phần	Đặc điểm
Pro	- Chiếm 15-20% thịt tươi - aa: nhiều lysin (hỗ trợ ngũ cốc), ít methionin; nhưng thịt rang, ướp

	đường, nướng làm giảm khả năng hấp thu Lysin
Lipid	Phần lớn acid béo no hoặc k no có 1 =
Glucid	- rất thấp, chỉ lượng nhỏ Glycogen trong gan
Vitamin	- thịt lợn nhiều B ₁ , bẽ nhiều PP - VTM C và tan trong dầu có chủ yếu ở gan, thận
Khoáng	- Thịt luộc toan mạnh vì chứa nhiều P và S - Ăn thịt rang, nướng khó hấp thu Lysin - Nước xương, thịt luộc có nhiều N nhưng k phải pro - Fe trong thịt 1-3 mg%, tỷ lệ hấp thu 30-40%

Bệnh	Đặc điểm	Xử trí
Than	Có ở da, phổi, ruột súc vật	Hủy toàn bộ
Lao	Phổi, lá lách, gan	-lao cục bộ → loại bỏ bộ phận bệnh, chế biến kỹ -lao toàn thể → hủy toàn bộ
Brucellose	Phủ tạng	Đun chín kỹ
Đóng dấu lợn		Hủy toàn bộ
Bò điên		Loại bỏ phần NT, chế biến kỹ phần còn lại
Sán dây	Lưỡi, tim, lưng, sườn, bụng, rau quả có lẫn trứng sán	Nấu chín
Giun xoắn	Như sán dây	Nấu chín
Thịt cóc	Da và buồng trứng chứa bufotonin, bufotoxin	Bỏ da và phủ tạng
Thịt bị hỏng	Chứa histamin và ptomain	Bỏ

2. Cá

a. Dinh dưỡng

- Chứa nhiều acid béo k no cần thiết, nhiều lysin giống thịt; Pro cao 16-17%
- Glucid 1%
- Lipid tốt hơn thịt; Nhiều khoáng và vtm hơn thịt
- Nước 55-83%
- Cá dễ bị hỏng hơn thịt

b. Bệnh

- Sán lá gan nhỏ → nấu chín

- Cá ươn chứa Histamin

3. Tôm cua nhuyễn thể

- Tôm nhiều Ca và P, rất dễ bị ươn, hỏng
- K sử dụng mực râu xanh vì có chất độc như cá nóc
- Nhuyễn thể chết → Mytilotoxin nên k đc ăn con chết, và phải nấu chín con sống

4. Trứng

- Pro lòng đỏ có thành phần aa tốt nhất và toàn diện nhất
- Trứng gà là nguồn Lecithin quý
- Không nên ăn lòng trắng trứng sống vì gây khó tiêu

5. Sữa

- Nhiều lysin, methionin, nhiều vtm A B
- Lipid của sữa có giá trị sinh học cao
- Sữa đv gọi là sữa casein, sữa người là albumin
- Bơ là nguồn vtm A và D, chứa nhiều oleic và palmitic

Nguồn gốc thực vật

NGŨ CỐC	-Vỏ ngoài chứa pro, vtm nhóm B, khoáng - mầm chứa acid béo, lecithin, vtm E K - Hạt chứa tinh bột	- glucid 72-80%, càng già trắng càng tăng glucid, giảm pro - pro chính: Glutelin, albumin, globulin. Lượng pro thấp hơn lúa mì và ngô nhưng giá trị SH cao hơn, so với trứng nghèo lysin hơn - ít Ca, nhiều P và (vtm B giảm nhiều qua xay xát) - gạo mốc chứa Aflatoxin → K gan nguyên phát → k nên trử gạo quá 3m
		- pro 8.5-10%, nhiều leucin, nghèo lysin và tryptophan - lipid 4.5% chủ yếu linoleic - nhiều vtm E và B1, nghèo Ca, P

		Bột mì: ít lysin, 11% pro Bánh mì: nhiều Fe, K, P
KHOAI CŨ	Glucid = 1/3 ngũ cốc, pro thấp Nhiều xơ, vtm, khoáng Mầm + vỏ potato mọc mầm chứa solanin → liệt cơ, chết người → k ăn/ gọt vỏ khoét mầm kỹ Sắn tươi sinh HCN → gọt vỏ, ngâm nước, luộc chín, ăn với đường	
ĐẬU ĐỎ	Pro cao 17-25% Nguồn PP, Ca, Fe	Đậu tương Pro max (34%), nhiều lipid hơn các loại đậu khác Đậu đỏ nói chung nghèo aa chứa S như methionin và cystein Đậu sống sinh HCN → giảm khả năng tiêu hoá và hấp thu dinh dưỡng → làm chín Mốc → aflatoxin
HẠT CỎ DẦU	Lạc: pro cao nhưng chất lượng kém hơn đậu đỏ (ít methionin); nhiều vtm B và acid béo Vừng: chất lượng pro tương đương lạc, nhiều methionin, nghèo lysin; nhiều vtm B Dầu thực vật: chứa nhiều acid béo k no cần thiết: oleic, linoleic, arachidonic	
RAU XANH	Men ascorbicnase (là enzym phân giải vtm C) được giải phóng khi rau bị giập nát → tránh mất vtm C khi nấu nướng Sắc màu cam của rau củ là carotene Cung cấp chất khoáng cần cho thăng bằng kiềm toan Ca:P = 1:0.6, thích hợp để đồng hoá	
QUẢ	Nhiều acid hữu cơ (làm quả có vị chua, dễ tiêu hoá), pectin và tanin hơn rau Ca:P dễ đồng hoá Fe hữu cơ + vtm C → dễ hấp thu	

Bài 3. CÁC VẤN ĐỀ DD CÓ Ý NGHĨA SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG

1. Thiếu dinh dưỡng Protein – Năng lượng

a. Đại cương

- Nguyên nhân
 - Ăn thiếu về cả số lượng và chất lượng các chất dinh dưỡng
 - Nhiễm khuẩn
 - Cân nặng sơ sinh thấp
- Phân loại nặng : (3)
 - **Thể teo đét (Maramos)** : SDD nặng do thiếu E
 - **Thể phù (Kwashiorkor)** : do chế độ ăn nghèo pro, ít gầy hơn
 - **Thể phối hợp** thiếu cả E và pro
- 2011 SDD nhẹ cân 16.8%, SDD thấp còi cao (27.5%), khác biệt đô thị và nông thôn, miền núi

b. Phân loại SDD TE thường gặp ở cộng đồng theo WHO 2005 (3) theo mức phổ biến giảm dần

- **Thấp còi** : chiều cao/tuổi thấp, phản ánh thiếu DD **thời gian dài** → phản ánh KTXH. Ở các nước đang PT, tỷ lệ thấp còi tăng nhanh sau 3m tuổi và ổn định từ 3y
- **Thể nhẹ cân** : cân nặng/tuổi thấp hơn tiêu chuẩn ($-2SD$), tuy nhiên k rõ SDD mới hay tích tụ từ lâu
- **Gầy còm** : cân nặng/chiều cao thấp. Phản ánh tình trạng **cấp tính**, max ở trẻ 2y. Trên LS chỉ số CN/CC quan trọng hơn cả

c. Ý nghĩa sức khỏe cộng đồng của SDD

- 1995 WHO : 54% tử vong liên quan SDD
- Liên quan bệnh : tiêu chảy và viêm phổi
- Liên quan phát triển hành vi và trí tuệ

d. Phòng chống

- Chăm sóc PNCT CCB
- Nuôi con bằng sữa mẹ : bú ngay trong 1h đầu, hoàn toàn trong 6m, tới 18-24m
- Số bữa ăn bổ sung

- trẻ 4-6 tháng tuổi là 2 lần/ngày
- Từ 6-12 tháng: 3-4 lần/ngày
- >12 tháng: 4-6 lần/ngày
- Khi cân nặng không tăng là biểu hiện đe dọa, nếu xuống cân là biểu hiện nguy hiểm

2. Thiếu máu dinh dưỡng

a. Định nghĩa

- Hb thấp hơn bt do thiếu yếu tố tạo máu, hay gặp nhất là thiếu máu do thiếu Fe, có thể kết hợp thiếu Folic
- Cao nhất ở Châu Phi, Châu Á rồi Mỹ Latinh
- Thiếu máu là giai đoạn cuối của quá trình thiếu Fe lâu dài → số người thiếu Fe chưa bộc lộ thiếu máu cao hơn nhiều số thiếu máu thực sự
- Chẩn đoán :
 - Sàng lọc cộng đồng : HGB, HCT (nhạy nhất)
 - Xét nghiệm chẩn đoán thiếu Fe : xác định = Ferritin huyết thanh (<12 ug/l → thiếu dự trữ Fe) ; hỗ trợ = (2) : mức bão hoà Transferin (bình thường 30% còn dưới 15%), Protoporphyrin tự do > 70 ug/l

b. Hậu quả

- Giảm năng suất LĐ (kể cả thiếu Fe chưa bộc lộ thiếu máu)
- Giảm năng lực trí tuệ
- Tăng nguy cơ sinh non, tỷ lệ mắc bệnh và tử vong mẹ-con

c. Nguyên nhân

- Nhu cầu tăng ở PNCT và tuổi sinh đẻ
- Nhiễm KST, đặc biệt giun móc
- ăn k đủ Fe hoặc bị ảnh hưởng hấp thu Fe

d. Phòng chống

- Truyền thông đa dạng hoá bữa ăn
 - Phối hợp thức ăn đv và đậu đỗ (để tăng khả năng hấp thu Fe nhờ vtm C)
 - Khuyến khích cách chế biến nảy mầm, muối chua (vì làm tăng hàm lượng vtm C, giảm Tanin và acid Phytic gây khó hấp thu Fe)
 - Bổ sung Fe- Folic cho phụ nữ 15-35y và phụ nữ có thai với liều
 - PNCT uống đều đặn ngày 1v từ lúc phát hiện có thai đến hết 1m sau sinh
 - PN khác: uống 1v/tuần vào ngày nhất định, uống 4^m/năm
 - Phòng giun móc
 - Tăng cường Fe trong TP

3. Thiếu vitamin A

VN vẫn nằm trong danh sách thiếu vtm A cận lâm sàng mức cao (16.9%), thường trẻ <6y

a. Nguyên nhân

- ăn thiếu (đặc biệt trẻ ăn dặm), kém hấp thu (ăn thiếu lipid, trẻ k được bú mẹ)
- tình trạng nhiễm trùng
- SDD protein- năng lượng

b. Chẩn đoán

- LS sớm nhất : quáng gà
- Vệt Bitot (triệu chứng đặc hiệu của tổn thương giác mạc do thiếu vtm A)
- Khô –loét-sẹo giác mạc
- Thiếu VTM A có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng nếu trong số trẻ từ 0-5 tuổi có tỷ lệ vượt 1 trong các ngưỡng sau
 - 1% có quáng gà hoặc
 - 0,5% có vệt Bitot hoặc
 - 0,1% khô giác mạc, loét nhuyến giác mạc hoặc
 - 0,05% có sẹo giác mạc

c. Phòng chống

- Truyền thông cải thiện bữa ăn (biện pháp dài hạn và vững chắc)
 - Sữa mẹ là nguồn vtm A tốt nhất với trẻ nhỏ
 - Cần có thức ăn từ động vật và đủ dầu mỡ
 - Bổ sung Carotene bằng các loại rau màu xanh đậm và quả màu cam
- Liều lượng VTM A cho các đối tượng:
 - Phụ nữ sau khi đẻ trong vòng 0 4 tuần: 200.000 UI
 - Trẻ từ 6 – 12 tháng: 100.000 UI
 - Trẻ từ 1 – 6 tuổi: 200.000 UI
 - Trẻ ko được nuôi bằng sữa mẹ từ 3 – 6 tháng: 50.000 UI
 - Trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi, cứ 3 – 6 tháng cho uống 1 lần
- Phòng nhiễm khuẩn (đb là sỏi) để phòng khô mắt sau sỏi
- Tăng cường vtm A trong thực phẩm

4. Thiếu iod

VN đã đạt được mục tiêu Quốc tế về loại trừ rối loạn do thiếu iod

a. Hậu quả

Thiếu hormone giáp → 'RL do thiếu iod' : bướu cổ, chậm pt trí tuệ, chiều cao, chậm pt sinh dục, sảy thai, đẻ non, thai chết lưu

b. Nguyên nhân

Do đất thiếu iod → cây trồng → động vật, con người thiếu

c. Phân loại – chẩn đoán

- 3 độ bướu cổ trên LS
- Định lượng iod nước tiểu : phản ánh đủ, thiếu, thừa (đủ khi từ 10 ug/dl)
- Quốc gia đạt 2/3 chỉ số được coi là không thiếu iod :
 - Toàn bộ muối ăn đc dùng cho người và gia súc được iod hoá
 - Iod niệu (>50% mẫu đạt 10, >80% đạt 5)
 - Bướu cổ trẻ em tuổi đi học <5%

d. Phòng chống

- Bổ sung iod cho mọi người sống trong vùng thiếu iod liên tục và lâu dài

5. Thừa cân béo phì

a. Đánh giá thừa cân béo phì

- Tỷ lệ phụ nữ > nam
- Tăng theo tuổi ở thành phố, giảm theo tuổi ở nông thôn
- Số liệu 2010 VN : <5y : 5.6%, PN tuổi sinh đẻ 8.2%
- Người lớn : theo BMI
- Trẻ em trên LS thường dùng chỉ số CN/CC
- Tỷ lệ eo/mông cao : >0.85 ở nữ, >1 ở nam
- Ngưỡng ở PN : <30% mỡ : bt ; <=30, <35 % mỡ : béo phì ; >=35% : béo phì thể nặng

b. Phương pháp thay đổi chế độ ăn

- Tạo cân bằng năng lượng âm tính 500-1000 Kcal/d → giảm 10% trọng lượng trong vòng 6m
- 1 tuần giảm 300 kcal so với khẩu phần
- Thành phần dinh dưỡng
 - Lipid giảm còn 15%
 - Đủ đạm, vtm, khoáng
 - Glucid : nhiều xơ (bánh mì đen, ngũ cốc nguyên hạt,...)
 - Rau quả chín : 500g/d
 - Muối hạn chế <6g/d, nếu THA thì nên 2-4 g/d
 - 3 bữa ăn/d, tránh rượu bia và chất kt

BAI 4. NGUYEN TẮC CHUNG TRONG DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ

1. Nguyên tắc chung (6)

- Bn phải dùng chế độ ăn quy định tại bệnh viện
- Xây dựng chế độ ăn cho từng bệnh, từng bệnh nhân, xây dựng nhiều thực đơn để thay thế
- Chú ý mức độ bệnh và cho bệnh nhân lựa chọn các mức phí dinh dưỡng khác nhau
- Có chế độ ăn cơ bản cho bệnh nhân cùng chỉ định
- Chế độ ăn đặc biệt cho bệnh phức tạp
- Nhân viên y tế xem ăn uống là phương pháp trị liệu để theo dõi

2. Nguyên tắc cơ bản

a. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng người bệnh

- Tìm hiểu tiền sử dinh dưỡng
- Phát hiện triệu chứng dinh dưỡng đặc hiệu
- Đánh giá dự trữ E
 - Lipid : độ dày nếp gấp da $<60\%$ $\rightarrow$ giảm dự trữ
 - Protein nội tạng : Albumin HT <3.5 g/dl

b. Xây dựng chế độ ăn (6)

- Nhiều option đảm bảo tính cân đối toàn diện
- Xác định thời hạn của các chế độ ăn không cân đối
- Quy định ăn uống ở những bệnh nhân trị liệu đặc biệt
- Phối hợp dinh dưỡng, điều trị và sử dụng thuốc
- Chế độ ăn phù hợp hoạt động của bệnh nhân
- Thực phẩm hạn chế rán, lựa chọn thức ăn dễ tiêu, nên nghiền như

c. Nguyên tắc thay thế thực phẩm

Tính lượng tương đương để giá trị khẩu phần k đổi

d. Nguyên tắc lựa chọn và chế biến thức ăn

e. Nguyên tắc vệ sinh TP

f. Nguyên tắc tổ chức ăn uống trong bệnh viện

- **Người lớn 12 CĐA, trẻ em 10**

Một số chế độ ăn điều trị

1. Chế độ ăn thông thường

Gần như người bình thường

2. Chế độ ăn hạn chế E

a. Bệnh ĐTĐ (I và II)

- Nguyên tắc
 - Đủ E để giữ cân bình thường, thừa cân thì giảm năng lượng
 - K nên dùng đường
 - Đảm bảo tỷ lệ chất sinh E
 - Chất xơ 20-40 g/d
 - Đủ vtm, đặc biệt nhóm B
 - Muối < 6g/d
- Chỉ số đường huyết: phản ánh mức đáp ứng của Glucoza máu sau khi ăn thực phẩm nào đó/chuẩn

3. Chế độ ăn giảm Pro

- Khẩu phần < 1 g/kg
- Trong suy thận, hôn mê gan, toan ceton, viêm đại tràng, RLTH, suy đa tạng

4. Chế độ ăn hạn chế Lipid

- Chỉ định: bệnh béo phì, bệnh túi mật

5. Chế độ ăn hạn chế muối

- Bình thường khẩu phần ăn gồm 10-15 g muối: 40% nấu: 40% có sẵn trong thực phẩm chế biến: 20% có sẵn thức ăn thiên nhiên
- 2 mức hạn chế: tuyệt đối (0.5-1 g) và tương đối (1.25-2.5 g)
 - Tuyệt đối: chế độ ăn chỉ cơm, quả, đường. k đc thịt, cá, sữa bò
 - Tương đối: thịt cá, trứng cua sữa, nội tạng. Khoong được dùng muối, nc mắm, đồ ướp muối
- Chỉ định: bệnh thận, tim, HA, xơ gan, PNCT 3-6m cuối

6. Chế độ ăn hạn chế xơ và chất kích thích

- Chỉ định: viêm loét dạ dày –TT, viêm ruột
- Hạn chế
 - Chặt chẽ: chỉ có sữa bột
 - TB: thêm khoai nghiền và trứng
 - Ít: ăn thịt mềm thái nhỏ, rau nghiền kỹ

7. Chế độ ăn hạn chế Purin

- Chỉ định: gout, bệnh calci thận
- <50 G PURIN/d (sữa k béo, bánh mì, ngũ cốc, gạo, khoai tây)

8. Chế độ ăn bệnh nhân bỏng

- Mức nhẹ: ăn 4h sau nhập viện
- TB- nặng: dinh dưỡng đường miệng 24-48h sau hồi sức

BÀI 5. DINH DƯỠNG DỰ PHÒNG BỆNH MÃN TÍNH

1. Tổng quan

- 2020 bệnh mãn tính sẽ chiếm gần ¾ tổng số case tử vong/ thế giới, trong đó K đứng đầu
- ĐTD sẽ tăng gấp đôi trên TG trong 30 năm tới, từ 143tr ca 1997 đến 300 triệu năm 2025
- Chế độ ăn chiếm 30% nguyên nhân gây K ở phương tây, 20% ở các nước ĐPT
- Tỷ lệ mắc K đại tràng của người Nhật ở Hawaii cao hơn ở Nhật, còn K dạ dày thấp hơn
- Ở VN từ sau năm 1995 tỷ lệ thừa cân tăng đáng kể
- Gần 1/3 người lớn ĐTD có liên quan đến béo phì, nguy cơ đau thắt ngực và NMCT
- Cuối tk 19, Keys và Cs cho rằng acid béo no là yếu tố chính của bệnh mạch vành

2. Yếu tố nguy cơ một số bệnh K

- K ĐTT: ăn nhiều chất béo, lười vận động, thừa cân
- K mũi họng: ăn nhiều cá muối
- K vú: béo phì và rượu, đồ nướng

3. Chế độ ăn

- **Chế độ ăn ảnh hưởng theo thu nhập**
 - Pro: năng lượng do Pro ít thay đổi theo thu nhập, chung quanh 12%
 - Lipid: thu nhập càng cao năng lượng do lipid càng cao (hầu hết nguồn gốc đv)
 - Glucid: thu nhập càng cao năng lượng chung cho glucid giảm nhưng đường ngọt tăng)
- **Chế độ ăn thích hợp + tập luyện phòng đc 30-40% K, mình chế độ ăn 20%.**
Cụ thể: Rau quả $\geq 7\%$ E, đường ngọt $\leq 10\%$ E, thịt đỏ $\leq 10\%$ E, chất béo $\geq 15\%$ E $\rightarrow$ k quá 35% người lao động nhiều, k quá 25% cộng đồng chuyển tiếp; rượu hạn chế $< 5\%$ E ở nam và 2.5% ở nữ
- **Vai trò của thực phẩm**
 - Hoá chất thực vật: chất có hoạt tính sinh học nhưng lượng nhỏ. VD: Chè có nhiều Flavonoid ức chế OXH; Isoflavon đậu tương: bảo vệ tim mạch
 - Vtm E phòng xơ vữa ĐM, thoái hoá võng mạc, thoái hoá TK, XH não
 - Vtm C ức chế nitrosamin (gây K)
 - Bioflavonoid (ở chè, rượu vang, nho) dự phòng bệnh mạch vành
 - Betacarotene giảm nguy cơ K và bệnh TM

Chuyên ngành

Bài 1. Tính cân đối của khẩu phần

1. Định nghĩa khẩu phần hợp lý

- Đủ nhiệt lượng theo nhu cầu
- Đủ chất dinh dưỡng cần thiết
- Cân đối chất dinh dưỡng

Cân đối năng lượng	12:18:70 → 14:20:66
Cân đối pro	Pro động vật (nói lên chất lượng của khẩu phần) nên 30-50% 1 g/30-35 Kcal
Lipid	Lipid nên 18-25%, nên + 5% cho vùng lạnh, -10% vùng nóng, dù sao cũng k nên vượt quá 30%; Nguồn gốc tv 30-50% Acid béo: no <=10%, k no 4-10%
Glucid	61-70%, Glu phức hợp 70%
Vitamin	1000 Kcal cần 0.4 mg B1: 0.55 mg B2: 6.6 mg PP
Khoáng	Ca:P (nói lên CB toan-kiềm của khẩu phần), nên 0.8-1.5 Ca:Mg= 1/0.6
Chất chống OXH	Vtm E, C beta carotene, Se, Zn

Bài 2. Dinh dưỡng hợp lý cho các lứa tuổi

a. Người trưởng thành

Bảng 4.1: Chuyển hoá cơ bản: được tính dựa vào cân nặng (W) của cơ thể tính bằng kg.

Nhóm tuổi (năm)	Chuyển hoá cơ bản (Kcal/ngày)	
	Nam	Nữ
18 - 30	$15,3 W + 679$	$14,7 W + 496$
30 - 60	$11,6 W + 879$	$8,7 W + 829$
Trên 60	$13,5 W + 487$	$10,5 W + 596$

Bảng 4.2: Mức độ lao động: nhẹ, trung bình hay nặng sẽ có những hệ số tương ứng.

Mức độ lao động	Nghề nghiệp	Hệ số
Nhẹ/Rất nhẹ	Cán bộ/nhân viên văn phòng, nội trợ cơ giới, giáo viên và hầu hết các nghề khác.	1,56
Vừa	Công nhân công nghiệp nhẹ, nội trợ không cơ giới, sinh viên, công nhân cửa hàng bách hoá...	1,75
Nặng	Lao động nông nghiệp trong vụ thu hoạch, quân nhân thời kỳ luyện tập, vận động viên thể thao...	2,05

- Lipid: 18-25% nhu cầu năng lượng trong đó lipid Tv 30-50%, lipid đv $\leq 60\%$

- Nhu cầu Vitamin ADEK, chất béo k chứa no phụ thuộc lipid, nhu cầu vitamin B phụ thuộc glucid

- Vitamin A: retinol chỉ trong động vật

Vào cơ thể caroten chuyển hóa 12:1 hoa quả chín, 22,24:1 với rau xanh

Nhu cầu vitamin A đề nghị: WHO: 750 ug/ngày; viên DD: 600

- Vitamin D: mọi đối tượng: 5ug; 51-60: 10; >60: 15ug/day

- Vitamin E: 12mg

▪ Vitamin nhóm B, cứ 1000kcal ăn vào: B1:B2:PP= 0.4:0.55:6.6

▪ Vitamin C: 70mg

▪ Khoáng

- Sắt (nhớ là từng thi vào đây)
 - Giá trị SH thấp (5%) khi khẩu phần thịt, cá <30 g/d hoặc vtm C <25 mg/d
 - TB (10%) khi thịt cá từ 30-90 g/d hoặc vtm C 25-75 mg/d
 - Cao (15%) khi thịt cá > 90, vtm C >75
- Kẽm
 - Giá trị SH cao (50%) : khẩu phần nhiều pro đv
 - TB (30%) lượng pro đv TB
 - Thấp (15%) : khẩu phần ít hoặc k có pro đv
 - Ngũ cốc làm giảm hấp thu Zn, đặc biệt ở trẻ bú mẹ
- Ca : 19-49y : 700 mg, >=50y : 1000 mg
- Iod
 - Hấp thu ở ruột non, 30% sử dụng ở tuyến giáp, còn lại đào thải qua đường niệu.
 - 150 ug/d

b. Phụ nữ có thai – CCB

▪ PNCT

- Sự thay đổi
 - 3 tháng đầu tăng 1-2 kg
 - 3 tháng giữa tăng 4-5 kg
 - 3 tháng cuối tăng 6-7 kg
 - Lượng máu 3m cuối tăng 35-40%, phần nhiều là huyết tương
- Nhu cầu dinh dưỡng
 - Vtm D và Fe tăng 100%
 - Năng lượng tăng 350 kcal giữa thai kỳ và 500 cuối thai kỳ

c. Phụ nữ CCB

- Để tạo 100 ml sữa cần 85 Kcal, 100 ml sữa chứa 67-70 kcal
- Trung bình mỗi ngày tạo 600-750 ml sữa
- Vtm D giữ nguyên như lúc thai kỳ, sắt về mức trước mang thai, vtm A bổ sung 1/3 so với trước mang thai

d. Lứa tuổi < 19

▪ Trẻ <1y

- Tăng 1 g cần 8 Kcal

- Nhu cầu năng lượng tính theo nhóm tuổi và ngày, k tính theo cân nặng
- Pro : phần lớn là pro đv
- Lipid : 6-7 g/kg, 30-45% năng lượng
- Glucid : 12-14 g/kg

Đặc điểm sữa mẹ

- Sữa albumin dễ hấp thu (25% ngay dạ dày)
- Lipid : 50% k no
- Glucid : beta- lactoza dễ tiêu hoá

Trẻ 1-9 y

- Nhu cầu năng lượng tăng từ 1200-1800 cho 3 nhóm tuổi, pro đv vẫn tỷ lệ cao
- Vtm A tăng từ 400-450-500 ug -----
- Vtm D 5 ug
- Ca : 500-600-700 mg cho 3 nhóm tuổi

Trẻ 10-18 y

- Vtm A 600, D 5 ug, Ca 1000
- Iod 120-150 tăng theo tuổi

Người cao tuổi

- Năng lượng : cứ tăng 10 y giảm 5% nhu cầu, từ 60 y, tăng 10 y giảm 10% nhu cầu
- K còn cần pro để tạo hình nên pro đv :tv = 1 :1
- Hạn chế lipid, tv = 1/3
- Vtm A 600, vtm D 15, Ca 1000

Bài 3. Điều tra khẩu phần

Tầm quan trọng điều tra khẩu phần

- Phát hiện sự thiếu hoặc thừa dinh dưỡng ngay giai đoạn đầu tiên
- Thu thập + phân tích số liệu → kết luận mối liên hệ ăn uống và tình trạng SK

1. Phương pháp điều tra trọng lượng LTTP (2)

a. Điều tra tổng quát về tiêu thụ lương thực TP

Dựa vào theo dõi CB TP

- TP sản xuất ra
- TP nhập hay mua về
- Dùng cho chăn nuôi
- Làm giống

- Nguyên liệu công nghiệp
- ✱ Dựa vào cơ cấu dân số → tính ra lượng TP tiêu thụ đầu người
- ✱ Nhược điểm :
 - Không cho biết tình hình khẩu phần thực tế các quần thể khác nhau
 - Đòi hỏi hệ thống thống kê chất lượng

b. Xác định LTTP theo trọng lượng

- ✱ Ưu điểm : pp chính xác nhất
- ✱ Nhược điểm
 - Cần nhiều nguồn lực
 - Đối tượng có thể thay đổi khẩu phần
 - Gây phiền hà dễ bị từ chối

2. Phương pháp hỏi ghi (6)

a. Phương pháp ghi sổ và kiểm kê

- Tiến hành đc ở cả bếp tập thể và trong gia đình
- Phối hợp chặt chẽ người nghiên cứu và phía gia đình
- Cách tiến hành
 - Bếp ăn tập thể : lấy số liệu mỗi tháng, quý ; trước đó kiểm kê lượng tồn kho
 - Hộ gia đình : lấy số liệu hàng ngày

b. Phương pháp ghi nhật ký

- Cần sự hợp tác của đối tượng
- Đối tượng ghi lại đồ ăn đã dùng trong 1-7d

c. Phương pháp hỏi tiền sử dinh dưỡng (dùng ở TE hoặc phát hiện bệnh liên quan dinh dưỡng trong 1 giai đoạn nhất định)

- Tần suất tiêu thụ TP
- Thức ăn ưa thích – k ưa thích
- Tường thuật cách ăn 3 d gần nhất

d. Điều tra tần suất tiêu thụ LTTP

- Vẽ ra bức tranh về bữa ăn của đối tượng, thể hiện thói quen ăn uống (tần suất)
- Không cung cấp về mặt số lượng → định tính → nhanh, rẻ tiền

e. Phương pháp nhớ lại 24h qua

- 2 cách hỏi : từ sáng → tối qua hoặc trong vòng 24h trước từ lúc đc hỏi
- Ưu điểm
 - đơn giản, nhẹ nhàng → đối tượng hợp tác
 - nhanh, đơn giản, chi phí thấp → áp dụng rộng rãi cho số đông đối tượng
- hạn chế
 - đối tượng k trung thực

- đối tượng quen
 - khó ước tính chính xác thực phẩm
- f. Phương pháp hồi ghi 24h nhiều lần
- tiến hành 3-7d liên tục hoặc nhắc lại ở các mùa khác nhau → đánh giá khẩu phần TB
 - Ưu điểm
 - Chú ý tới ảnh hưởng các ngày ăn cải thiện như ngày lễ, ngày nghỉ → mức tiêu thụ LTTP đánh giá chính xác hơn
3. Điều tra tập quán ăn uống
- Để xác định được nguyên nhân → giáo dục hiệu quả
 - a. Phương pháp phỏng vấn và trò chuyện
 - b. Phương pháp quan sát
 - c. Phương pháp thảo luận nhóm (8-12 người) có trọng tâm
4. Bảng thành phần thực phẩm VN
- 526 thực phẩm, xếp thành 14 nhóm
 - Số liệu về thành phần dinh dưỡng tính/100 g thực phẩm ăn đc sau khi sơ chế
5. Tổ chức điều tra tiêu thụ LTTP : 4 BƯỚC

Bài 4. Điều tra ngộ độc TP

- ĐN : bệnh lý do hấp thụ TP bị ô nhiễm hoặc chứa chất độc
- 4 loại : do VSV/ hoá chất/ chất độc có sẵn/ thức ăn biến chất

1. Ngộ độc TP do VSV

- a. Tác nhân
 - Vi khuẩn : salmonella, E.coli, tụ cầu vàng,...
 - Virus : adenovirus, Hepatitis, E.histolytica,...
- b. Biểu hiện LS
 - ủ bệnh 6-48h
 - triệu chứng : RLTH chính, nặng có shock
 - thường xảy ra vào mùa hè, phổ biến, thường nhẹ
 - tìm thấy mầm bệnh trong thức ăn, chất nôn, phân

2. ngộ độc TP do hoá chất

- a. tác nhân
 - hoá chất BVTV
 - Chất phụ gia, bảo quản

- Kim loại nặng, hoá chất độc từ đất

b. Lâm sàng

- ủ bệnh ngắn : vài phút -> vài h
- triệu chứng : hội chứng thần kinh
- mềm bệnh tìm thấy trong thức ăn, chất nôn, máu

3. ngộ độc TP do bản thân chất độc tự nhiên

a. tác nhân

- solanin : mềm khoai tây
- HCN : sắn, măng
- Glucozid trong quả họ đậu
- Saponin trong hạt sỏ, vỏ, rễ cây
- Muscarin nấm độc
- Hepatoxin, tetrodonin trong gan và buồng trứng cá nóc
- Bufotoxin trong gan, trứng cóc
- Mytilotoxin trong nhuyễn thể

b. Lâm sàng

- ủ bệnh TB 2-4h, có thể ngắn hơn
- phát bệnh : triệu chứng TK + TH. Tử vong cao
- xác định chất độc dựa vào dịch tể và triệu chứng lâm sàng đặc thù

4. ngộ độc TP do thức ăn bị biến chất

- ủ bệnh ngắn : 2-4h
- phát bệnh : HC tiêu hoá + một số triệu chứng do đạm biến chất (dị ứng, thần kinh)

5. quy định về NĐTP

- khi có bn, yt địa phương báo cáo cho TTYT trong vòng 24h kể từ khi chẩn đoán
- thu giữ thực phẩm, lấy chất nôn, phân, nước rửa dạ dày gửi đến TT YTDP hoặc viện chuyên ngành xét nghiệm

a. 9 bước điều tra NĐTP

- Nắm vững dịch tể địa phương để phân biệt NĐTP hay dịch
- Điều tra trước khi ngộ độc 48h, ít nhất là 24h
- Khai thác đầy đủ triệu chứng LS
- Lưu giữ mẫu thức ăn, nôn, phân, dịch rửa dạ dày, .. ; lấy mẫu gửi xét nghiệm
- Xét nghiệm ngay khi nhận đc mẫu
- Điều tra vệ sinh môi trường, nguồn thực phẩm, nơi chế biến, bảo quản, nhân viên, ..
- Nghi ngờ ngộ độc do VSV cần xét nghiệm người ngộ độc, nhân viên phục vụ
- Có người tử vong cần kết hợp bên Công an và pháp y
- Tổng hợp kết quả, kết luận, đề ra biện pháp xử lý

b. Quy định về khai báo

- Từ người mắc
- Từ nhân viên YT
- Từ người lãnh đạo, quản lý (doanh nghiệp, trường học, cơ quan,...)
- Báo cáo lên cấp trên → thủ trưởng phán đoán cử đội điều tra xuống hoặc yêu cầu viện trợ từ cấp trên

c. Phương pháp điều tra : theo bộ phiếu

Bài 5. Giám sát dinh dưỡng

a. Định nghĩa

Quá trình theo dõi liên tục nhằm cung cấp dẫn liệu hiện có về tình hình dinh dưỡng nhân dân và yếu tố liên quan → can thiệp kịp thời

b. Mục tiêu

- Mô tả tình hình dinh dưỡng nhân dân
- Phân tích, phát hiện vấn đề dinh dưỡng → dự báo và xây dựng đường lối
- Theo dõi can thiệp dinh dưỡng và đánh giá hiệu quả
- Nhận định khuynh hướng các vấn đề dinh dưỡng

c. Nội dung giám sát

- Vấn đề dinh dưỡng
- Đối tượng nguy cơ nhất
- Phân lập nguyên nhân (chú ý chuỗi hiện tượng)
- Diễn biến vấn đề dinh dưỡng

d. Chỉ tiêu giám sát (yêu cầu nhạy, đặc hiệu, dễ thu thập)

Một số chỉ tiêu hay dùng :

- Nhân trắc, hoá sinh
 - Cân nặng sơ sinh
 - Cân nặng/ tuổi
 - Chiều cao/tuổi
 - Vòng cánh tay (độ nhạy thấp) : ≥ 13.5 bình thường, 12.5-13.4 báo động ; < 12.5 SDD ; < 11.5 SDD nặng
 - () Đánh giá mức độ phổ biến của SDD tại cộng đồng : 5-9% thấp ; 10-19 : TB ; 20-39% cao ; $\geq 40\%$ rất cao
 - ■ Đánh giá mức độ thiếu máu quàn thể : $\leq 4.9\%$ bt ; 5-19.9% nhẹ ; 20-39% trung bình ; $\geq 40\%$ nặng
- Tử vong đặc hiệu theo tuổi

ở các nước ĐPT để đánh giá tình trạng thiếu DD quan tâm 2 chỉ số tử vong trẻ 0-1 y và 1-4y

- Chỉ tiêu KTXH và nông nghiệp
- Thói quen liên quan đến dinh dưỡng (hút thuốc, uống rượu)

BÀI 7. Tư vấn dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện

phương pháp : trực tiếp/ gián tiếp

a. Trực tiếp

- Hiệu quả nhất
- Gồm 3 loại : nhóm (nhóm 8-12 người, tổ chức 1-2 tuần/lần), cá nhân (60 m), thăm hộ gia đình

b. Gián tiếp (qua điện thoại, tờ rơi, loa đài,...)

c. Các bước (6)

- Tạo mối quan hệ, tìm hiểu mục đích tư vấn của người bệnh
- Phân tích tiền sử bệnh và dinh dưỡng + đánh giá thực hành ăn uống của bệnh nhân
- Cung cấp tư liệu liên quan chăm sóc dinh dưỡng của bệnh nhân, đưa ra giải pháp
- Hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn giải pháp thích hợp nhất
- Giúp người bệnh có kế hoạch hành động
- Theo dõi và hỗ trợ thường xuyên

Bài 8. Các chất phụ gia và bảo quản thực phẩm

Chất phụ gia

- Thành phần của thực phẩm (với giới hạn tối đa cho phép) nhằm cải thiện kết cấu hoặc đặc tính kỹ thuật của thực phẩm ; phân biệt với chất hỗ trợ chế biến (có mặt trong thực phẩm như một tồn dư không mong đợi)
- 274 chất phụ gia chia làm 6 nhóm : điều vị/cải thiện kết cấu/ bảo quản/ giữ màu/ bột màu/nhũ hoá
- Lợi ích
 - Tạo đc nhiều sản phẩm phù hợp khẩu vị người tiêu dùng
 - Giữ đc chất lượng thực phẩm toàn vẹn đến khi sử dụng (chất bảo quản)
 - Tăng giá trị thương phẩm
 - Kéo dài thời gian sử dụng TP
- Nguy hại
 - Gây ngộ độc cấp tính
 - Ngộ độc mạn : dùng liều nhỏ, liên tục
 - Nguy cơ hình thành khối u, đột biến gen
 - Nguy cơ ảnh hưởng chất lượng thực phẩm (dùng Anhydrid sulfuro bảo quản rượu vang sẽ phá huỷ B1)

Bài 9. Lập kế hoạch truyền thông GD và chăm sóc dinh dưỡng cộng đồng

Bài này xem thêm slides màu cam

1. Định nghĩa

- Lập kế hoạch can thiệp dinh dưỡng là đề ra mục tiêu để giải quyết vấn đề DD cụ thể + tìm biện pháp đạt đc mục tiêu
- Bản kế hoạch cần chỉ rõ các bước tiến hành + thước đo hiệu quả

2. Các phương pháp lập kế hoạch can thiệp (3)

a. Từ trên xuống

- Cán bộ lãnh đạo lập → mang tính áp đặt, k có sự tham gia cộng đồng → xa rời thực tế, thiếu ủng hộ từ cộng đồng
- Ưu điểm :
 - Nhanh, đơn giản
 - Dựa vào những kế hoạch đã triển khai trước đó nên khá chính xác
 - K liên quan đến nhiều người
- Nhược điểm
 - Gây phản ứng tiêu cực từ cấp dưới
 - Mang tính chủ quan người lập kế hoạch
 - Có thể thiếu tính thực tiễn

b. Từ dưới lên

- Dựa vào nhu cầu thực tế của người dân
- Ưu điểm
 - Tạo động lực cho nhân viên tham gia lập kế hoạch
 - Cấp dưới thường ước tính nguồn lực chính xác hơn
 - Tăng khả năng cấp dưới nhận đc ngân sách
 - Cung cấp kinh nghiệm cho cấp dưới
- Nhược điểm
 - Phức tạp, tốn thời gian
 - Nguy cơ cấp dưới đưa ra chi phí tăng vọt so với nhu cầu → tạo sự nghi ngờ từ cấp trên

c. Phối hợp

- Kế hoạch sát thực tế, có tính khả thi, chấp nhận
- Hiệu quả can thiệp cao
- Nâng cao năng lực cộng đồng

lập kế hoạch truyền thông : 3 giai đoạn, 7 bước (không hiểu cái nổi gì cả)



Bài 10. Vệ sinh ATTP tại cơ sở SX, CB và KD thực phẩm

1. Điều kiện về cơ sở

a. Địa điểm, môi trường

- Cơ sở sx, kd phải bố trí cách xa các khu vực ô nhiễm, ứ nước, rác thải,..; có đường nội bộ, rãnh thoát nước khép kín
- Nhà xưởng
 - Cách biệt giữa khu sx và không sx
 - Khu vực sx thiết kế nguyên tắc 1 chiều
 - Có kho bảo quản TP
 - Trần, tường, sàn nhà sơn sáng màu
 - Chú ý hệ thống chiếu sáng > 200 lux
- Nhà vệ sinh
 - 25 người/1 wc
 - Cuối hướng gió
 - Cách ly hoàn toàn khu chế biến

b. Trang thiết bị

- Vật liệu bền, không độc, dễ tháo lắp làm sạch, bảo dưỡng
- 50 người/bồn rửa tay

TEST DINH DƯỠNG - AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐẦY ĐỦ VÀ MỚI NHẤT

NGUYÊN TẮC DINH DƯỠNG DỰ PHÒNG CÁC BỆNH MẠN TÍNH

Hãy chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng ở đầu một ý đúng nhất cho các câu dưới đây:

1. Béo phì làm tăng nguy cơ bệnh nào sau đây

- A. Bệnh tim mạch và đái tháo đường
- B. Bệnh tim mạch và tăng huyết áp
- C. Bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp

D. Bệnh tim mạch, đái tháo đường và tăng huyết áp

2. Chế độ ăn chiếm ưu thế của những người có huyết áp thấp là.

A. Nguồn gốc động vật

B. Nguồn gốc thực vật

C. Chế độ ăn chứa nhiều muối

D. Chế độ ăn có ít kali

3. Chế độ ăn có liên quan đến mắc bệnh tim mạch

A. Nhiều axit amin

B. Nhiều axit béo no

C. Nhiều axit béo chưa no

D. Nhiều axit béo n-3

4. Nguyên tắc dinh dưỡng dự phòng các bệnh mạn tính

A. Phối hợp nhiều loại thực phẩm và cân đối giữa các thực phẩm nguồn gốc động vật và thực vật

B. Sử dụng các thực phẩm ở mức độ vừa phải và tăng cường các hoạt động thể lực

C. Cả hai nguyên tắc ở mục a và b

D. Tất cả các nguyên tắc ở mục a và b trừ nguyên tắc tăng cường các hoạt động thể lực

5. Để dự phòng các bệnh mạn tính có liên quan đến dinh dưỡng thì lượng rau sử dụng hàng ngày được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo

A. 200 g

B. 300 g

C. >400 g

D. 500 g

6. Để dự phòng các bệnh mạn tính có liên quan đến dinh dưỡng, tổng số chất béo no trong khẩu phần được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo không nên vượt quá.

A. 5 %

B. 10 %

C. 15 %

D. 20 %

7. Những bệnh mạn tính có liên quan đến dinh dưỡng nào sau đây có xu hướng gia tăng trên thế giới và Việt Nam?

- A. Đái đường và tăng huyết áp
- B. Đái đường và các bệnh tim mạch
- C. Tăng huyết áp và thừa cân-béo phì

D. Đái đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và thừa cân-béo phì

8. Trong xã hội xuất hiện cả thiếu dinh dưỡng và thừa dinh dưỡng, khẩu phần ăn của các đối tượng nhân dân có xu hướng chuyển từ chế độ ăn giàu thức ăn thực vật sang chế độ ăn giàu thức ăn động vật. Đây được gọi là giai đoạn gì ?

- A. Chuyển tiếp về dịch tễ học
- B. Chuyển tiếp về dinh dưỡng
- C. Chuyển tiếp về kinh tế
- D. Chuyển tiếp về mô hình bệnh tật

9. Đặc điểm béo của người trưởng thành Việt Nam mắc thừa cân và béo phì là gì ?

- A. Béo toàn thân
- B. Béo tay chân
- C. Béo bụng (kiểu nam)
- D. Béo phủ tạng

10. Những người nhiều nguy cơ mắc các bệnh mạn tính có liên quan dinh dưỡng là những người nào sau đây ?

- A. Làm công việc hành chính
- B. Thiếu ngủ về ban đêm.
- C. Ít hoạt động thể lực hàng ngày
- D. Ăn nhiều

11. Yếu tố nào sau đây góp phần làm gia tăng các bệnh mạn tính có liên quan đến dinh dưỡng?

- A. Chế độ ăn và gen di truyền.

B. Gen di truyền và lối sống.

C. Lối sống và chế độ ăn.

D. Phương tiện giao thông hiện đại.

12. Chế độ ăn nào sau đây sẽ làm giảm nguy cơ đối với hầu hết các loại ung thư?

A. Chế độ ăn giàu chất béo

B. Chế độ ăn nhiều cá muối

C. Chế độ ăn đủ rau và hoa quả

D. Chế độ ăn chứa nhiều thực phẩm xử lý ở nhiệt độ cao

13. Theo đề nghị của Viện Dinh Dưỡng về mục tiêu và lối sống ở Việt Nam hiện nay thì khẩu phần ăn hàng ngày nên có lượng muối ăn là bao nhiêu?

A. < 5 gam

B. < 10 gam

C. < 15 gam

D. < 20 gam

14. Theo Tổ chức Y tế thế giới dự báo trong 30 năm tới bệnh đái đường trên thế giới sẽ tăng gấp mấy lần?

A. Một lần rưỡi

B. Hai lần

C. Hai lần rưỡi

D. Ba lần

15. Tỷ lệ thừa cân – béo phì ở Việt Nam bắt đầu tăng lên từ năm nào?

A. Sau năm 1985

B. Sau năm 1990

C. Sau năm 1995

D. Sau năm 2000

16. Trong phân tích của FAO (1962) về mối liên quan giữa thu nhập và cơ cấu khẩu phần cho thấy đặc điểm chế độ ăn ở các nước thu nhập thấp như thế nào?

A. Nghèo thức ăn động vật và nghèo chất béo

B. Nguồn năng lượng chủ yếu do Glucid cung cấp

C. Nghèo thức ăn động vật và giàu Glucid

D. Nghèo chất béo, giàu Glucid và nghèo thức ăn động vật.

17. Trong phân tích của FAO (1962) về mối liên quan giữa thu nhập và cơ cấu khẩu phần cho thấy đặc điểm chế độ ăn ở các nước thu nhập cao như thế nào?

A. Nhiều thức ăn động vật

B. Lượng Glucid phức hợp giảm và đồ ngọt tăng.

C. Nhiều chất béo, nhiều thức ăn động vật, nhiều đồ ngọt và lượng Glucid phức hợp giảm.

D. Nhiều thức ăn động vật và nhiều chất béo

18. Một chế độ ăn thích hợp cùng với rèn luyện thể lực có thể phòng ngừa các trường hợp ung thư tới:

A. 10 – 20%

B. 20 – 30%

C. 30 – 40% (trong khi đó riêng ăn uống phòng đc 20% K)

D. 40 – 50%

19. Các chất dinh dưỡng có vai trò chống Oxy hoá là:

A. Vitamin A, B, C, E

B. Vitamin A, C, D, E

C. Vitamin C, E, K và Carotenoid

D. Vitamin C, E, Carotenoid

20. Cơ chế tác dụng của các chất chống oxy hoá là:

A. Ngăn ngừa oxy hoá Lipoprotein có tỷ trọng thấp (LDL)

B. Ngăn ngừa oxy hoá Lipoprotein có tỷ trọng cao (HDL)

C. Ngăn ngừa oxy hoá LDL - Cholesterol

D. Ngăn ngừa oxy hoá HDL - Cholesterol

21. Flavonoid có tác dụng ức chế oxy hoá LDL có nhiều trong:

A. Hành tỏi

B. Cà rốt

C. Rau xanh

D. Chè, nho, cacao

22. Chất nào trong đậu tương có tác dụng làm giảm Cholesterol huyết thanh:

A. Carotenoid

B. Polyphenol

C. Isoflavon

D. Thioallyl

23. Theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới, tổng lượng đường trong khẩu phần ăn không nên vượt quá:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

24. Theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới, lượng thịt đỏ trong khẩu phần ăn không nên vượt quá:

A. 10% năng lượng hàng ngày

B. 20% năng lượng hàng ngày

C. 30% năng lượng hàng ngày

D. 40% năng lượng hàng ngày

25. Theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới, tổng năng lượng từ Lipid ở các cộng đồng đang trong thời kỳ chuyển tiếp không nên vượt quá:

A. 15 – 20%

B. 20 – 25%

C. 25 – 30%

D. 30 – 35%

TEST LƯỢNG GIÁ BÀI: CHĂM SÓC DINH DƯỠNG Ở CỘNG ĐỒNG

Hãy chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng ở đầu một ý đúng nhất cho các câu dưới đây:

1. Thiếu dinh dưỡng ở cộng đồng do

- A. Những nguyên nhân đơn lẻ
- B. Một vài nguyên nhân đặc hiệu
- C. Phối hợp nhiều nguyên nhân
- D. Chỉ do thiếu kiến thức

2. Can thiệp dinh dưỡng đặc hiệu gồm các chương trình sau, trừ:

- A. Chương trình bổ sung vacxin Viêm não Nhật Bản vào lịch tiêm chủng mở rộng
- B. Chương trình phục hồi dinh dưỡng
- C. Chương trình bổ sung Vitamin A và viên sắt
- D. Chương trình thức ăn bổ sung cho bà mẹ và trẻ em

3. Chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng cần

- A. Gắn với quá trình phát triển cộng đồng
- B. Gắn với công tác điều trị
- C. Phối hợp với phát triển cơ sở điều trị
- D. Phối hợp với tuyên truyền

4. Chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng cần dựa trên nguyên tắc

- A. Giải quyết tất cả các vấn đề dinh dưỡng
- B. Lựa chọn ưu tiên đối tượng có nguy cơ cao của vấn đề dinh dưỡng
- C. Giải quyết tất cả các vấn đề thực phẩm
- D. Giải quyết tất cả các đối tượng thiếu dinh dưỡng

5. Chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng cần yếu tố sau:

- A. Phối hợp liên ngành
- B. Phối hợp với ngành nông nghiệp
- C. Phải là cộng đồng nghèo
- D. Chỉ cần phát hiện vấn đề thiếu dinh dưỡng ở cộng đồng

6. Hoạt động chăm sóc dinh dưỡng trong chương trình Y tế có những nguyên tắc cơ bản sau trừ:

- A. lồng ghép thể hiện ở cả mục tiêu của dinh dưỡng và Y tế
- B. lồng ghép ở cả các hoạt động
- C. lồng ghép chỉ dựa trên cơ sở ghép những yêu cầu riêng rẽ
- D. lồng ghép cần phải thể hiện ở tất cả những hoạt động phát triển cộng đồng.

7. Hoạt động chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng cần

- A. Chỉ có hoạt động của Y tế
- B. Chỉ có hoạt động của chính quyền
- C. Sự tham gia của cộng đồng
- D. Hoạt động của ban ngành chức năng

8. Công tác chăm sóc dinh dưỡng được thể hiện ở

- A. Công tác khám và điều trị tại bệnh viện
- B. Công tác phòng bệnh nói chung
- C. Những hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu
- D. Những hoạt động vệ sinh thực phẩm

9. Chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai yêu cầu trong quá trình mang thai người mẹ tăng cân từ.

- A. 6-7 kg
- B. 7-8 kg

C. 10-12 kg

D. 12-14 kg

10. Trong thời kì mang thai người mẹ có thể có nguy cơ cao bị

A. Thiếu năng lượng trường diễn

B. Thừa cân và béo phì

C. Thiếu vitamin D

D. Thiếu vitamin B1

11. Sau khi sinh bà mẹ nên cho trẻ bú

A. Ngay sau khi sinh trong vòng 1 giờ

B. Ngay sau khi sinh trong vòng 1-6 giờ đầu

C. Nên cho trẻ bú sau 6 giờ đầu

D. Nên cho trẻ bú sau 24 giờ

12. Cho trẻ ăn bổ sung vào tháng thứ

A. Tháng thứ 4

B. Tháng thứ 5

C. Tháng thứ 6

D. Tháng thứ 7

13. Lợi ích chính của theo dõi biểu đồ phát triển ở trẻ để

A. Xác định trẻ bị suy dinh dưỡng

B. Phát hiện sớm chiều hướng của tình trạng dinh dưỡng

C. Có giải pháp phù hợp kịp thời khi trẻ bị suy dinh dưỡng ???

D. Phân biệt thể suy dinh dưỡng

14. Đường biểu diễn sự phát triển cân nặng của trẻ khi theo hướng nằm ngang có ý nghĩa

A. Trẻ phát triển bình thường

B. Trẻ có thể đe dọa bị suy dinh dưỡng

C. Trẻ đã bị suy dinh dưỡng

D. Trẻ đang bị suy dinh dưỡng.

15. Can thiệp dinh dưỡng ở cộng đồng biện pháp hiệu quả nhất là:

A. Những can thiệp trực tiếp

- B. Những can thiệp gián tiếp
- C. Can thiệp về đường lối dinh dưỡng
- D. Những can thiệp phối hợp

16. Chương trình can thiệp dinh dưỡng đặc hiệu bằng bổ sung thức ăn cho trẻ em có thể:

- A. Thay thế hoàn toàn các bữa ăn của trẻ
- B. Bổ sung một phần để đáp ứng đủ nhu cầu
- C. Bổ sung thêm những chất dinh dưỡng thiếu
- D. Thay thế bữa ăn ở gia đình

17. Để phòng thiếu máu dinh dưỡng, phụ nữ có thai nên uống bổ sung viên sắt và acid folic từ:

- A. Từ khi phát hiện có thai
- B. Tháng thứ 4
- C. Tháng thứ 5
- D. Tháng thứ 6

17. Để phòng bệnh thiếu Vitamin A và khô mắt cho trẻ em, chậm nhất trong vòng 1 tháng sau sinh, trẻ em cần được uống Vitamin A liều cao

- A. 100.000 đơn vị
- B. 200.000 đơn vị
- C. 300.000 đơn vị
- D. 400.000 đơn vị

18. Chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con bú ở cộng đồng cần các yêu cầu sau, trừ:

- A. Uống bổ sung viên sắt và acid folic
- B. Hướng dẫn bà mẹ cách ăn uống và lao động hợp lý trong thời kỳ có thai
- C. Cho trẻ uống Vitamin A liều cao ngay sau sinh
- D. Cho trẻ uống Vitamin D ngay sau sinh

19. Có thể dự báo nguy cơ và mức độ suy dinh dưỡng ở cộng đồng dựa vào:

- A. Tỷ lệ trẻ tham gia tiêm chủng mở rộng đầy đủ
- B. Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai định kỳ
- C. Tỷ lệ trẻ em được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu
- D. Theo dõi biểu đồ tăng trưởng ở cộng đồng

20.

Chương trình bổ sung thức ăn cho đối tượng có nguy

cơ cao là:

- A. Chương trình can thiệp dinh dưỡng bằng giáo dục truyền thông
- B. Chương trình can thiệp về đường lối dinh dưỡng
- C. Chương trình can thiệp dinh dưỡng đặc hiệu
- D. Phối hợp cả 3 chương trình trên

21. Chương trình can thiệp bằng giáo dục truyền thông dinh dưỡng dựa trên cơ sở:

- A. Thay đổi kiến thức, thái độ của đối tượng
- B. Thay đổi kiến thức, thực hành của đối tượng
- C. Thay đổi thái độ, thực hành của đối tượng
- D. Thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành của đối tượng

22.

Mục đích của can thiệp dinh dưỡng bằng giáo dục

truyền thông nhằm:

- A. Giải quyết vấn đề dinh dưỡng của cộng đồng
- B. Cải thiện và giải quyết vấn đề bệnh tật của cộng đồng
- C. Cải thiện và giải quyết vấn đề dinh dưỡng của cá nhân, gia đình và cộng đồng
- D. Cải thiện và giải quyết vấn đề dinh dưỡng, bệnh tật của cá nhân, gia đình và cộng đồng

TEST LƯỢNG GIÁ BÀI: TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG

Hãy chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng ở đầu một ý đúng nhất cho các câu dưới đây:

1. Mục tiêu cuối cùng của truyền thông giáo dục dinh dưỡng là.

- A. Thay đổi kiến thức và quan điểm theo hướng có lợi cho dinh dưỡng

- B. Thay đổi quan điểm theo hướng có lợi cho dinh dưỡng
- C. Thay đổi một hành động theo hướng có lợi cho dinh dưỡng.
- D. Thay đổi kiến thức theo hướng có lợi cho dinh dưỡng
2. Trong một chương trình truyền thông dinh dưỡng, các thông điệp nên đưa ra
- A. Nền ưu tiên theo từng giai đoạn của chương trình.
- B. Khi chương trình ở giai đoạn bắt đầu
- C. Khi chương trình ở giai đoạn giữa
- D. Khi chương trình ở giai đoạn cuối
3. Khi cần tiến hành truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho một nhóm bà mẹ có cùng hoàn cảnh nuôi con nhỏ hoặc đang trong thời kì mang thai, nên sử dụng hình thức nào sau đây?
- A. Thăm gia đình bà mẹ
- B. Mở lớp dạy cách nuôi con khỏe
- C. Thảo luận nhóm
- D. Tư vấn dinh dưỡng
4. Một bà mẹ có con bị suy dinh dưỡng nhưng không đưa con đến trạm y tế theo dõi cân nặng thường xuyên, nên giáo dục dinh dưỡng cho bà mẹ này bằng cách?
- A. Đọc tên trên loa phóng thanh của xã
- B. Yêu cầu bà mẹ tham dự câu lạc bộ cách nuôi con khỏe
- C. Chờ lễ phát động nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 hàng năm
- D. Thăm gia đình đối tượng
5. Hình thức truyền thông giáo dục dinh dưỡng tiếp cận được nhiều đối tượng nhất là:
- A. Tư vấn dinh dưỡng
- B. Thảo luận nhóm
- C. Thăm gia đình đối tượng
- D. Trên các phương tiện thông tin đại chúng
6. Trong chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại các địa phương, đối tượng ưu tiên số 1 để truyền thông giáo dục dinh dưỡng là:

- A. Đối tượng sẽ thay đổi hành vi sau khi thực hiện chương trình.
- B. Đối tượng có ảnh hưởng đến sự thay đổi hành vi của nhóm đích
- C. Đối tượng quan trọng sẽ hỗ trợ cho các hoạt động truyền thông
- D. Đối tượng sẽ hưởng lợi ích từ chương trình
7. Nhóm đối tượng nào sau đây là đối tượng hỗ trợ công tác truyền thông giáo dục dinh dưỡng?
- A. Người chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ ở cộng đồng
- B. Cô nuôi dạy trẻ
- C. Hội phụ nữ
- D. Các ông bà trong gia đình
8. Để đánh giá hiệu quả của một buổi truyền thông giáo dục dinh dưỡng trực tiếp, yếu tố cần thiết là:
- A. Kênh truyền đạt
- B. Thông tin truyền đạt
- C. Thông tin phản hồi
- D. Yếu tố nhiễu
9. Truyền thông giáo dục dinh dưỡng là một biện pháp can thiệp dinh dưỡng.
- A. Trực tiếp
- B. Gián tiếp
- C. Kết hợp trực tiếp và gián tiếp
- D. Không cần xác định nhóm đích
10. Khi hướng dẫn nội dung khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ nên khuyến bà mẹ cho con bú kéo dài đến:
- A. 12 tháng
- B. 18 tháng
- C. 24 tháng
- D. 36 tháng
11. Lời khuyên khi sử dụng chất béo trong bữa ăn hàng ngày nên chú ý:
- A. Tăng ăn dầu thực vật
- B. Ăn một lượng mỡ vừa phải
- C. Ăn cân đối mỡ và dầu thực vật
- D. Ăn cân đối mỡ và dầu thực vật, ăn thêm vùng - lạc

13. Lời khuyên nào sau đây thuộc lời khuyên thứ 7 về vệ sinh an toàn thực phẩm

- A. Rửa tay trước khi ăn và sau khi ăn
- B. Rửa tay sau khi ăn và trước khi chế biến thức ăn
- C. Rửa tay trước khi ăn và trước khi chế biến thức ăn
- D. Rửa tay trước và sau khi chế biến thức ăn

14. Nguồn truyền đạt thông tin trong quá trình truyền thông dinh dưỡng cần đảm bảo:

- A. Ngắn gọn, rõ ràng, hấp dẫn và phù hợp
- B. Tin cậy và thuyết phục
- C. Đảm bảo tính tiếp cận được
- D. Sẵn sàng và tích cực

15. Đối tượng ưu tiên 1 của truyền thông giáo dục dinh dưỡng là:

- A. Đối tượng có ảnh hưởng đến sự thay đổi hành vi của nhóm ưu tiên 2
- B. Đối tượng có ảnh hưởng đến sự thay đổi hành vi của nhóm ưu tiên 3
- C. Đối tượng sẽ thay đổi hành vi sau khi thực hiện chương trình
- D. Đối tượng quan trọng sẽ hỗ trợ cho các hoạt động truyền thông

16. Thảo luận nhóm trong truyền thông giáo dục dinh dưỡng bao gồm các nội dung sau, trừ:

- A. Trao đổi, chia sẻ thông tin về 1 chủ đề đang được quan tâm
- B. Cộng tác viên cung cấp kiến thức cho các đối tượng tham gia thảo luận nhóm
- C. Cộng tác viên phải chuẩn bị về chủ đề, câu hỏi, tình huống liên quan
- D. Cân và đo chiều cao cho trẻ và tư vấn cho bà mẹ

17. Các hình thức sau là hình thức truyền thông trực tiếp, trừ:

- A. Tư vấn dinh dưỡng qua điện thoại
- B. Thảo luận nhóm
- C. Tư vấn dinh dưỡng
- D. Thăm gia đình đối tượng

DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ SỨC KHỎE-ĐẠI CƯƠNG



1. Các hợp chất chứa nitơ cần thiết cho sự sống được gọi là protein vào:

A. Nửa sau thế kỷ 18

B. Nửa đầu thế kỷ 19

C. Nửa sau thế kỷ 19

D. Nửa đầu thế kỷ 20

2. Nhà bác học đã xác định được 8 acid amin cần thiết là:

A. Osborne

B. Mendel

C. Thomas

D. Rose

3. Người đầu tiên phân lập được các acid béo là nhà bác học:

A. Chevreul

B. Mendel

C. Thomas

D. Rose

4. Những nghiên cứu về mối liên quan giữa số lượng và chất lượng chất béo trong khẩu phần với bệnh tim mạch được bắt đầu nghiên cứu vào:

A. Nửa sau thế kỷ 19

B. Nửa đầu thế kỷ 20

C. Nửa sau thế kỷ 20

D. Đầu thế kỷ 21

5. Dinh dưỡng học được coi là một bộ môn khoa học độc lập vào:

A. Thế kỷ 17

B. Thế kỷ 18

C. Thế kỷ 19

D. Thế kỷ 20

6. Quá trình tiêu hoá là quá trình:

A. Cơ học

B. Hoá học

C. Vật lý học

D. Sinh học

7. Các chất khoáng được thừa nhận là các chất dinh dưỡng vào:
- A. Thế kỷ 17
 - B. Thế kỷ 18
 - C. Thế kỷ 19
 - D. Thế kỷ 20
8. Vitamin có nghĩa là:
- A. Các amin cần cho sự sống
 - B. Các vi chất dinh dưỡng
 - C. Các chất cần thiết trong thức ăn
 - D. Các chất dinh dưỡng đặc biệt
9. Người đề nghị gọi tên các vitamin theo các chữ cái A, B, C, D, E... là:
- A. Mc Collum
 - B. Lind
 - C. Funk
 - D. Schmidt
10. Nước đầu tiên đưa ra "bảng nhu cầu các chất dinh dưỡng" cho con người là:
- A. Mỹ
 - B. Nga
 - C. Anh
 - D. Đức
11. Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam do Viện Dinh dưỡng soạn thảo đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt vào năm :
- A. 1995
 - B. 1996
 - C. 1997
 - D. 1998
12. Viện Dinh dưỡng quốc gia được thành lập vào năm:

A. 1975

B. 1980

C. 1985

D. 1990

13. Tình trạng dinh dưỡng có *ảnh hưởng lớn* lên quá trình tiến triển của bệnh:

A. Lao

B. Bạch hầu

C. Đậu mùa

D. Thương hàn

14. Vitamin được gọi "Vitamin chống nhiễm khuẩn" là:

A. Vitamin A

B. Vitamin E

C. Vitamin C

D. Vitamin D

15. Chất dinh dưỡng mà khi thiếu cơ thể sẽ ngừng hoặc chậm tăng trưởng là:

A. Các acid amin cần thiết

B. Calci

C. Sắt

D. Vitamin A

16. Chất dinh dưỡng mà thiếu cơ thể vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhưng đến một lúc nào đó sẽ có những biểu hiện lâm sàng đặc hiệu là:

A. Các acid amin cần thiết

B. Natri

C. Vitamin A

D. Kali

17. Ảnh hưởng của tình trạng dinh dưỡng đến các quá trình tiến triển các bệnh nhiễm khuẩn:

- A. Mức độ nặng của bệnh
 - B. Mức độ kéo dài của bệnh
 - C. Khả năng phục hồi sau bệnh
 - D. Cả 3 đặc điểm trên
18. Bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng là:
- A. Đái đường
 - B. Khô mắt do thiếu vitamin A
 - C. Cao huyết áp
 - D. Loãng xương
19. Nhà khoa học phát hiện ra vai trò của chanh đối với bệnh hoại huyết là
- A. Lind
 - B. Funk
 - C. Mc Collum
 - D. Schmidt
20. Một chất dinh dưỡng được hấp thu vào cơ thể sẽ có vai trò
- A. Riêng biệt
 - B. Tương hỗ với các chất dinh dưỡng khác
 - C. Chỉ sinh ra năng lượng
 - D. Không tương hỗ với các chất dinh dưỡng khác
21. Thành phần cấu trúc của cơ thể
- A. Luôn cân bằng
 - B. Thế cân bằng động
 - C. Thế cân bằng động cần các chất dinh dưỡng duy trì
 - D. Thế cân bằng do bản thân cơ thể duy trì
22. Nguyên nhân suy dinh dưỡng Protein năng lượng do thiếu
- A. Potein
 - B. Năng lượng

C. Vitamin

D. Protein và năng lượng và nhiễm trùng

23. Nguyên nhân gốc rễ của suy dinh dưỡng ở cộng đồng là

A. Bệnh tật nhiều

B. Thiếu cơ sở khám chữa bệnh

C. Đói nghèo

D. Không có nước sạch

24. Nguyên nhân gốc rễ của suy dinh dưỡng ở cộng đồng là

A. Không tiêm chủng

B. Không khám thai

C. Thiếu kiến thức

D. Giao thông không thuận tiện

25. Vấn đề dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng ở nước ta hiện nay là

A. Còi xương

B. Pelagra

C. Suy dinh dưỡng

D. Thiếu B₂

26. Vấn đề dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng ở nước ta hiện nay là

A. Thiếu can xi

B. Loãng xương

C. BeriBeri

D. Thiếu máu thiếu sắt

27. Vấn đề dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng ở nước ta hiện nay là

A. Thiếu kẽm

B. Thiếu vitamin B₁₂

C. Thiếu Iode

D. Thiếu selen

28. Hiện nay ở nước ta vấn đề dinh dưỡng có nghĩa sức khỏe cộng đồng là

A. Thiếu vitamin B₁

B. Thiếu vitamin K

C. Thiếu vitamin A

D. Thiếu vitamin D

29. Ở nước ta bắt đầu xuất hiện vấn đề sức khỏe là

A. Thừa Vitamin

B. Thừa chất khoáng

C. Thừa cân và béo phì

D. Cholesterol cao

30. Thiếu dinh dưỡng ảnh hưởng tới

A. Yếu tố miễn dịch tăng

B. Sức chống đỡ với nhiễm trùng giảm

C. Trẻ ít bị cảm nhiễm với bệnh nhiễm trùng

D. Trẻ tăng sức đề kháng với các bệnh nhiễm trùng

31. Suy dinh dưỡng ảnh hưởng tới

A. Cân nặng

B. Chiều cao

C. Cân nặng và chiều cao

D. Cân nặng, chiều cao và trí tuệ

32. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi ở nước ta hiện nay là:

A. 40-50%

B. 30-40%

C. 20-30%

D. 10-20%

33. Nguyên nhân trực tiếp của suy dinh dưỡng

A. Chế độ ăn thiếu cân đối các chất dinh dưỡng

B. Chế độ ăn kém chất lượng

C. Chế độ ăn kém cả số lượng và chất lượng

D. Chế độ ăn thiếu vitamin

34. Trẻ sau sinh nên được bú

A. Trong vòng 3 tiếng đầu

- B. Trong vòng 6 tiếng đầu
- C. Trong vòng nửa tiếng đầu
- D. Trước 24 giờ sau sinh

35. Đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng ở cộng đồng sử dụng chỉ số cân nặng theo tuổi với thang phân loại suy dinh dưỡng sau

- A. Cân nặng trẻ dưới $\bar{X} - 1SD$
- B. Cân nặng trên $\bar{X} - 2SD$
- C. Cân nặng dưới $\bar{X} - 2.5SD$
- D. Cân nặng dưới $\bar{X} - 2SD$

36. Nguyên nhân dẫn đến trẻ bị thiếu vitaminA ở cộng đồng do

- A. Trẻ ăn thiếu vitaminA
- B. Khẩu phần ăn thiếu carotene
- C. Khẩu phần ăn thiếu vitamin A+carotene
- D. Khẩu phần thiếu chất béo+ VitaminA+ carotene

37. Trẻ em bị thiếu vitaminA và khô mắt có thể liên quan với

- A. Thiếu vitamin D
- B. Thiếu vitaminD
- C. Thiếu canxi
- D. Bệnh nhiễm trùng

38. Cộng đồng có nguy cơ thiếu vitamin A cao là:

- A. Vùng trung du
- B. Vùng đồng bằng
- C. Miền núi, cao nguyên
- D. Ven những sông lớn

39. Ngưỡng đánh giá lâm sàng khô mắt do thiếu vitaminA có nghĩa sức khỏe cộng đồng

- A. Cần phải phối hợp nhiều chỉ tiêu

B. Chỉ cần một dấu hiệu lâm sàng vượt trên ngưỡng

C. Cần 2 chỉ tiêu quầng gà và vệt bitot vượt trên ngưỡng

D. Vệt bitot với khô giác mạc vượt trên ngưỡng

40. Cho trẻ trên 12 tháng uống vitamin A với liều lượng

A. 50.000UI

B. 100.000UI

C. 200.000UI

D. 300.000UI

41. Đối tượng cho uống vitamin A liều cao

A. Phụ nữ cho con bú

B. Phụ nữ mang thai

C. Phụ nữ sau sinh trong vòng 1 tháng

D. Phụ nữ đang độ tuổi sinh đẻ

42. Ở nước ta, hiện tại vấn đề khô mắt không còn cao ở mức có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng nên

A. không cần triển khai tiếp tục chương trình phòng chống

B. chỉ triển khai trọng điểm từng vùng

C. tiếp tục triển khai toàn diện chương trình

D. chỉ triển khai chương trình cho uống liều cao Vitamin A

43. Trong các biện pháp phòng chống thiếu Vitamin A và khô mắt, biện pháp thuộc chiến lược lâu dài và bền vững là:

A. Cải thiện chế độ ăn

B. Cho uống Vitamin A liều cao

C. Tăng cường Vitamin A vào thực phẩm

D. Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và nước sạch

44. Ngưỡng Hb nào trong máu sau đây được coi là có thiếu máu dinh dưỡng nặng khi dưới:

A. Dưới 12g/100ml

B. Dưới 11g/100ml

C. Dưới 10g/100ml

D. Dưới 7g/100ml

45. Thiếu máu dinh dưỡng có nguyên nhân do.

- A. Chỉ do thiếu sắt trong khẩu phần
- B. Chỉ do thiếu các chất dinh dưỡng
- C. Thiếu các chất dinh dưỡng phối hợp với các bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng
- D. Các bệnh nhiễm ký sinh trùng

46. Khẩu phần nào dưới đây có lượng sắt hấp thu khoảng 15% là:

- A. Thịt cá 30g Vitamin C dưới 25mg
- B. Thịt cá 30-90g Vitamin C từ 25-75mg
- C. Thịt cá > 90g, Vitamin C trên 75mg
- D. Thịt cá > 90g, vitamin C dưới 75mg

47. Các biện pháp phòng chống thiếu máu dinh dưỡng hiện nay là:

- A. Cho uống viên sắt Folat
- B. Cải thiện chế độ ăn + uống viên sắt
- C. Cải thiện chế độ ăn + uống viên sắt + cải thiện điều kiện môi trường
- D. Cải thiện chế độ ăn + uống viên sắt + điều trị bệnh giun sán

48. Thiếu iode niệu ở nước ta hiện nay

- A. 12%
- B. 15%
- C. 30%
- D. 35%

49. Ảnh hưởng nặng nề của thiếu iode

- A. Bướu cổ
- B. Thiếu năng tuyến giáp
- C. Thiếu năng trí tuệ
- D. Giảm khả năng lao động

50. Những đối tượng nào sau đây nếu bị thiếu iode sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.

- A. Người trưởng thành
- B. Thiếu niên
- C. Phụ nữ mang thai

D. Phụ nữ cho con bú

51. Tình trạng thiếu iode ảnh hưởng tới

A. Phụ nữ

B. Trẻ em

C. Cả cộng đồng

D. Người trưởng thành

52. Đánh giá thiếu iode ở cộng đồng ở mức nhẹ khi tỷ lệ bướu cổ ở trẻ em

A. 10-25%

B. 15-30%

C. 5-20%

D. 5-25%

53. Đánh giá thiếu iode ở cộng đồng ở mức trung bình khi tỷ lệ bướu cổ ở trẻ em

A. 15-35%

B. 20-30%

C. 20-40%

D. 10-30%

54. Đánh giá thiếu iode ở cộng đồng ở mức nặng khi tỷ lệ bướu cổ ở trẻ em

A. Trên 35%

B. Trên 30%

C. Trên 40%

D. Trên 25%

55. Để phòng thiếu iode ở cộng đồng sử dụng muối iode cho đối tượng

A. Phụ nữ có thai

B. Trẻ em dưới 15 tuổi

C. Mọi người dân

D. Phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ

56. Dầu iode hóa nên dùng cho đối tượng

A. Bà mẹ mang thai

B. Nam giới trên 45 tuổi

C. Trẻ em dưới 15 tuổi

D. Người đang bị ốm

57. Muối iode từ nhà máy đến bữa ăn có thể

A. Hàm lượng vẫn đảm bảo

B. Hàm lượng bị hao hụt rất ít

C. Không bảo quản tốt hàm lượng còn dưới 50%

D. Không bảo quản tốt sẽ mất tới 30%

58. Nguyên nhân dẫn đến thừa cân và béo phì là:

A. Chế độ ăn cân đối, đủ chất dinh dưỡng

B. Cơ thể hấp thu tốt

C. Chế độ ăn thừa năng lượng

D. Chế độ ăn thừa protein

59. Nguyên nhân dẫn đến thừa cân và béo phì là:

A. Hoạt động thể lực nhiều

B. Hoạt động thể lực ít

C. Cơ thể sử dụng nhiều năng lượng

D. Cơ thể có cân bằng năng lượng âm tính

60. Thừa cân và béo phì

A. Chỉ ảnh hưởng đến cấu trúc cơ thể

B. Có liên quan đến bệnh tiêu hóa

C. Liên quan đến bệnh van tim

D. Liên quan đến bệnh tim mạch

61. Thừa cân và béo phì

A. Liên quan với bệnh tiểu đường phụ thuộc insuline

B. Liên quan tới cả hai typ đái đường

C. Liên quan với đái đường typ II

D. Liên quan với đái đường typ I

62. Để phát hiện thừa cân và béo phì ở người trưởng thành chỉ số BMI bằng

A. Cân nặng(kg)/Chiều cao(cm)

B. Cân nặng (g)/Chiều cao(m)

C. Cân nặng(kg)/Chiều cao(m)

D. Cân nặng (kg)/ {Chiều cao(m)}²

63. Khuyến cáo để dự phòng thừa cân và béo phì tập trung vào.

A. Chỉ cần chế độ ăn hợp lý

B. Hoạt động thể lực nhiều

C. Phối hợp ăn uống hợp lý và lối sống năng động

D. Ăn uống ít chất béo và đường

64. Thừa cân và béo phì ở nước ta hiện nay chỉ có ở

A. Chỉ xảy ra ở các thành phố lớn

B. Có cả ở các đô thị nhỏ

C. Cả thành phố và nông thôn

D. Thành phố và đô thị nhỏ

Ngọc

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VỆ SINH CỦA CÁC NHÓM THỰC PHẨM

Hãy khoanh tròn vào chữ đứng đầu một ý trả lời mà bạn cho là đúng nhất:

Câu hỏi khó:

A. Hàm lượng Protein trong thịt chiếm:

A. 10 - 15% trọng lượng tươi

B. 15 - 20% trọng lượng tươi

C. 20 - 25% trọng lượng tươi

D. 25 - 30% trọng lượng tươi

B. Giá trị sinh học của protein phụ thuộc vào các yếu tố sau, trừ:

A. Sự có mặt đầy đủ các acid amin cần thiết

B. Hàm lượng của các acid amin cần thiết

- C. Tỷ lệ cân đối các chất sinh năng lượng
- D. Tỷ lệ cân đối các acid amin cần thiết
- C. Hàm lượng Protein trong thịt phụ thuộc nhiều vào các yếu tố sau, TRỪ:
- A. Độ tuổi của súc vật
- B. Loại súc vật
- C. Cân nặng của súc vật
- D. Chế độ nuôi dưỡng
- D. Thịt, cá là những thức ăn gây toan vì: (nhiều P và S)
- A. Hàm lượng sắt cao
- B. Hàm lượng vitamin C cao
- C. Hàm lượng calci cao
- D. Hàm lượng phospho cao
- E. Dấu hiệu đặc trưng nhất để phát hiện một cốc sữa bị nhiễm khuẩn là:
- A. Có một lớp váng sữa ở trên mặt
- B. Cốc sữa bị thay đổi về màu sắc
- C. Cốc sữa có vị chua khi ngửi
- D. Có hiện tượng kết tủa trong cốc sữa
- F. Lipid trong lòng đỏ trứng có giá trị sinh học cao vì có chứa một lượng lớn chất:
- A. Cholesterol
- B. Lecithin
- C. Các acid béo chưa no cần thiết
- D. Vitamin A
- G. Loại thực phẩm có chất lượng protein tốt nhất là:
- A. Thịt
- B. Cá
- C. Trứng
- D. Đậu tương
- H. Gạo đóng các vai trò chính cung cấp cho khẩu phần các chất sau, TRỪ:
- A. Cung cấp glucid

B. Cung cấp Protein

C. Cung cấp vitamin B1

D. Cung cấp beta caroten

I. Trong protein của bột mì có chứa loại protein nào mà các loại lương thực khác không có:

A. Albumin

B. Globulin

C. Prolamin

D. Glutelin

J. Độc tố aflatoxin thường gặp trong các loại thức ăn có chứa nhiều:

A. Protein

B. Lipid ???

C. Glucid

D. Vitamin D

K. Để nâng cao giá trị sinh học của protein nên sử dụng phối hợp đậu đỗ với:

A. Khoai củ

B. Ngũ cốc

C. Rau xanh

D. Quả chín

L. Nhóm thức ăn phối hợp có giá trị sinh học của protein được nâng cao lên rõ rệt nhất là:

A. Đậu tương - Vừng - Gạo

B. Đậu tương - Vừng - Ngô

C. Đậu xanh - Lạc - Khoai lang

D. Lạc - Vừng - Khoai lang

Câu hỏi trung bình:

M. Giá trị dinh dưỡng của thịt cao hơn hẳn cá về:

A. Chất lượng protein

B. Hàm lượng các chất khoáng

C. Chất lượng lipid

D. Hàm lượng vitamin B1

- N. Giá trị dinh dưỡng của cá cao hơn hẳn thịt về:
- A. Hàm lượng protein
 - B. Hàm lượng lipid
 - C. Chất lượng lipid
 - D. Hàm lượng vitamin C
- O. Chất béo có hàm lượng vitamin A và vitamin D cao nhất là:
- A. Dầu cá
 - B. Dầu thực vật
 - C. Mỡ lợn
 - D. Bơ
- P. Casein của sữa bị kết tủa ở điều kiện:
- A. Nhiệt độ cao
 - B. Nhiệt độ cao và O_2
 - C. Môi trường acid
 - D. Môi trường kiềm
- Q. Albumin của sữa bị kết tủa ở điều kiện:
- A. Nhiệt độ cao
 - B. Nhiệt độ cao và O_2
 - C. Môi trường acid
 - D. Môi trường kiềm
- R. Trong các loại thực phẩm sau có thể có chứa chất độc gây ngộ độc, TRỪ:
- A. Nấm
 - B. Khoai tây
 - C. Khoai lang
 - D. Sắn
- S. Trong nhóm ngũ cốc và khoai củ, loại lương thực có chứa hàm lượng caroten cao nhất là:
- A. Gạo
 - B. Khoai tây
 - C. Khoai lang nghệ

- D. Ngô vàng
- T. Loại quả chín có hàm lượng Vitamin C cao nhất là:
- A. Cam
 - B. Chanh
 - C. Bưởi
 - D. Chuối
- U. Hoa quả chín là nguồn cung cấp chính cho khẩu phần:
- A. Vitamin C
 - B. Vitamin A
 - C. Vitamin B1
 - D. Vitamin PP
- V. Rau xanh có các vai trò quan trọng sau trong khẩu phần, TRỪ:
- A. Tạo phân, chống táo bón
 - B. Đào thải cholesterol và các độc chất bám trên thành ruột
 - C. Cung cấp Vitamin C
 - D. Kích thích tiết dịch vị dịch ruột

Câu hỏi dễ:

- W. Phương pháp xử lý thịt súc vật khi bị mắc bệnh giun xoắn là:
- A. Bỏ những phần bị bệnh
 - B. Chế biến kỹ thành thức ăn chín
 - C. Huỷ toàn bộ
 - D. Huỷ toàn bộ và triệt để
- X. Cách phân loại thực phẩm đang được áp dụng hiện nay ở cộng đồng là:
- A. Phân theo 3 nhóm thực phẩm
 - B. Phân theo 4 nhóm thực phẩm
 - C. Phân theo 5 nhóm thực phẩm
 - D. Phân theo 6 nhóm thực phẩm
- Y. Phương pháp xử lý thịt súc vật khi bị mắc bệnh than là:
- A. Bỏ những phần bị bệnh

- B. Chế biến kỹ thành thức ăn chín
- C. Huỷ toàn bộ
- D. Huỷ toàn bộ và triệt để
- Z. Phương pháp xử lý thịt súc vật khi bị mắc bệnh sốt làn sống là:
- A. Bỏ những phần bị bệnh
- B. Chế biến kỹ thành thức ăn chín
- C. Huỷ toàn bộ
- D. Huỷ toàn bộ và triệt để
- Æ. Phương pháp xử lý thịt súc vật khi bị mắc bệnh lao phổi là:
- A. Huỷ toàn bộ những bộ phận có tổn thương lao, phần còn lại chế biến kỹ và sử dụng được
- B. Chế biến kỹ thành thức ăn chín
- C. Huỷ toàn bộ phủ tạng
- D. Huỷ toàn bộ
- BB. Trong sữa tươi, casein ở dạng liên kết với:
- A. Kali
- B. Calci
- C. Phospho
- D. Sắt
- À. Sữa là nguồn thực phẩm cung cấp tốt nhất về:
- A. Vitamin D
- B. Calci
- C. Vitamin A
- D. Sắt
- AA. Các loại khoáng chất và vitamin của trứng chủ yếu tập trung ở:
- A. Vỏ cứng
- B. Vỏ mỏng
- C. Lòng trắng trứng
- D. Lòng đỏ trứng

BB. Loại trứng ít bị nhiễm bẩn hơn cả là:

A. Vịt

B. Gà

C. Ngan

D. Ngỗng

CC. Để đảm bảo giá trị dinh dưỡng của gạo, khi xay xát gạo cần phải:

A. Để lại lớp cám

B. Chỉ xay xát vừa phải

C. Xay xát kỹ

D. Xay xát thật trắng

DD. Ăn gạo xay xát trắng có thể mắc bệnh:

A. Suy dinh dưỡng

B. Còi xương

C. Beri Beri

D. Pellagra

TEST LƯỢNG GIÁ BÀI: VỆ SINH ĂN UỐNG CÔNG CỘNG,

VỆ SINH BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MỘT SỐ THỰC PHẨM

Câu hỏi khó:

1. Khái niệm thực phẩm là:

A. Những thức ăn, đồ uống của con người dưới dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến bao gồm cả đồ uống, nhai, ngậm và các chất được sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

B. Những thức ăn của con người dưới dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến bao gồm cả đồ uống, nhai, ngậm và các chất được sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

C. Những thức ăn, đồ uống của con người dưới dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến bao gồm cả đồ uống, nhai, ngậm.

D. Những thức ăn, đồ uống của con người dưới dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến và các chất được sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

2. Khái niệm thức ăn đường phố là:

A. Là các loại thức ăn được bày bán trên đường phố và những nơi công cộng với mục đích dùng để ăn ngay hoặc ăn sau đó nhưng không được chế biến hoặc sử lý tiếp.

B. Các loại lương thực, thực phẩm được bày bán trên đường phố và những nơi công cộng với mục đích dùng để ăn ngay.

C. Những thức ăn, rau, hoa quả tươi sống bày bán trên đường phố với mục đích dùng để ăn ngay hoặc ăn sau đó nhưng không được chế biến hoặc sử lý tiếp.

D. Những thức ăn, đồ uống kể cả rau, hoa quả tươi sống bày bán trên đường phố và những nơi công cộng với mục đích dùng để ăn ngay hoặc ăn sau đó nhưng không được chế biến hoặc sử lý tiếp

3. Địa điểm của cơ sở dịch vụ, phục vụ ăn uống phải bố trí cách xa những nơi có nguy cơ nhiễm bẩn ít nhất là:

A. 30 m

B. 40 m

C. 50 m

D. 60 m

4. Để đảm bảo vệ sinh đối với dụng cụ ăn uống trực tiếp (bát, đĩa, thìa, đũa), ở các nơi ăn uống công cộng, phải được sát trùng lần cuối ở nhiệt độ tối thiểu là:

A. 60°C

B. 70°C

C. 80°C

D. 90°C

5. Nơi bày bán thức ăn đường phố phải cao hơn mặt đất ít nhất là:

A. 40 cm

B. 50 cm

C. 60 cm

D. 70 cm

6. Các cơ sở bán thức ăn đường phố phải đáp ứng các yêu cầu vệ sinh sau, TRỪ:

- A. Đảm bảo đủ nước sạch
- B. Phải cách xa nguồn ô nhiễm ít nhất 50 m ???
- C. Người làm dịch vụ chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức và được khám sức khỏe định kỳ
- D. Nhân viên phục vụ phải có tạp dề, đeo khẩu trang, đội mũ khi bán hàng.

7. Để đảm bảo giá trị dinh dưỡng của thức ăn cần chế biến:

- A. Trong thời gian ngắn với nhiệt độ cao
- B. Trong thời gian dài với nhiệt độ cao
- C. Trong thời gian ngắn với nhiệt độ vừa phải
- D. Trong thời gian dài với nhiệt độ vừa phải

8. Quá trình chế biến thực phẩm có thể làm:

- A. Tăng hàm lượng vitamin C trong thức ăn
- B. Tăng hàm lượng protein trong thức ăn
- C. Tăng khả năng gây độc cho người ăn
- D. Tăng hàm lượng cholesterol trong thức ăn

9. Để đảm bảo lưu giữ thực phẩm được lâu khi bảo quản khô, độ ẩm trong thực phẩm sau khi phơi, sấy phải dưới:

- A. 10-13%
- B. 13-16%
- C. 15-20%
- D. 20-25%

10. Khi bảo quản thực phẩm bằng phương pháp bảo quản mặn, nồng độ muối phải đạt tối thiểu là:

- A. 5 - 10%
- B. 10 - 15%
- C. 15 - 20%
- D. 20 - 25%

11. Bảo quản thực phẩm bằng phương pháp bảo quản ngọt, nồng độ đường phải đạt tối thiểu trên:

- A. 30%
- B. 40%
- C. 50%
- D. 60%

12. Để có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, pH của thực phẩm trong phương pháp muối chua phải đạt:

- A. 5,5
- B. 5,0
- C. 4,5
- D. 4,0

Câu hỏi trung bình:

13. Các cửa hàng sau được xếp vào nhóm thức ăn đường phố, TRỪ:

- A. Cửa hàng bún chả
- B. Cửa hàng cơm bình dân
- C. Cửa hàng bán giò chả ???
- D. Cửa hàng bán hoa quả dầm

14. Nguyên tắc một chiều cần phải được tuân theo ở:

- A. Khu nhà kho
- B. Khu vệ sinh
- C. Khu bếp ăn
- D. Khu phòng ăn

15. Dụng cụ chứa đựng và chế biến thực phẩm phải đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh sau, TRỪ:

- A. Bền đẹp
- B. Bề mặt nhẵn, dễ cọ rửa
- C. Được làm từ nguyên liệu không độc
- D. Không bị thực phẩm ăn mòn

16. Để đảm bảo giá trị dinh dưỡng của thực phẩm đông lạnh, khi làm tan đá cần phải:
- A. Để tan đá dần dần trong không khí ở nhiệt độ môi trường
 - B. Để tan đá dần dần trong ngăn mát tủ lạnh
 - C. Ngâm thịt vào nước ấm để làm tan băng
 - D. Ngâm thịt vào nước lạnh để làm tan băng
17. Cách sử dụng mộc nhĩ, nấm hương tốt nhất là:
- A. Chế biến khi còn tươi ngay sau khi thu hoạch
 - B. Ngâm mộc nhĩ, nấm hương tươi vào nước nóng sau 1 giờ mới chế biến
 - C. Ngâm mộc nhĩ, nấm hương tươi vào nước lạnh sau 2 giờ mới chế biến
 - D. Phơi thật khô rồi mới chế biến
18. Cách sử dụng tỏi tốt nhất là:
- A. Ngâm tỏi tươi vào dấm trước khi ăn
 - B. Ngâm tỏi khô vào dấm trước khi ăn
 - C. Phơi khô, bóc vỏ, đập dập nát trước khi ăn
 - D. Phơi khô, bóc vỏ và ăn nguyên cả nhánh tỏi
19. Cơ chế để giết vi khuẩn khi bảo quản ngọt là:
- A. Tăng áp lực thẩm thấu
 - B. Giảm nồng độ pH
 - C. Giảm nồng độ oxy
 - D. Giảm hàm lượng nước
20. Cơ chế để ức chế hoặc giết vi khuẩn khi bảo quản thực phẩm bằng cách lên men là:
- A. Tăng áp lực thẩm thấu
 - B. Giảm nồng độ pH
 - C. Giảm nồng độ oxy
 - D. Giảm hàm lượng nước
21. Bảo quản thực phẩm bằng phương pháp muối chua có thể:
- A. Diệt được một số loại vi khuẩn
 - B. Loại trừ được thuốc trừ sâu
 - C. Diệt được toàn bộ trứng giun

D. Loại trừ được nitrat có trong rau

22. Phương pháp bảo quản thực phẩm có thể diệt được hầu hết các vi khuẩn là:

A. Bảo quản ngọt với nồng độ đường 30%

B. Bảo quản mặn với nồng độ muối 30%

C. Bảo quản lạnh

D. Bảo quản bằng cách lên men

Câu hỏi dễ:

23. Bảo quản thực phẩm bằng phương pháp bảo quản lạnh sẽ:

A. Tiêu diệt được toàn bộ vi khuẩn

B. Tiêu diệt được các vi khuẩn không ưa lạnh

C. Làm ngừng sự phát triển của vi khuẩn

D. Tăng cường sự phát triển của vi khuẩn ưa lạnh

24. Để hạn chế việc giảm hàm lượng các chất dinh dưỡng, nhất là Vitamin C trong bảo quản thực phẩm bằng phương pháp muối chua, thời gian bảo quản nên dưới:

A. 7 ngày

B. 10 ngày

C. 15 ngày

D. 20 ngày

25. Những người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống cần đáp ứng các yêu cầu vệ sinh sau, TRỪ:

A. Phải được học những kiến thức về vệ sinh thực phẩm

B. Phải khám sức khỏe trước khi hành nghề

C. Phải được xét nghiệm phân ít nhất mỗi năm 1 lần.

D. Khi bị bất cứ bệnh gì phải báo cáo.

26. Những người trực tiếp bán thức ăn chín ăn ngay cần đáp ứng các yêu cầu vệ sinh sau, TRỪ:

- A. Phải giữ vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, cắt móng tay
- B. Phải đội mũ, đeo khẩu trang, đeo găng tay để bốc, chia thức ăn chín
- C. Không được nói chuyện, cười đùa trong khi bán hàng
- D. Không được ăn uống, nhai kẹo cao su, hút thuốc lá trong bếp
27. Tại các cơ sở bán thức ăn đường phố, qui trình rửa bát đĩa phải theo các bước thứ tự như sau:
- a. Rửa bằng nước ấm 45 - 50°C
- b. Loại bỏ các thức ăn sót lại trong bát đĩa
- c. Rửa bằng nước ấm 45 - 50°C với nước xà phòng
- d. Sát trùng bát đĩa bằng cách nhúng vào nước nóng trên 80°C.
- A. a, c, b, d
- B. b, c, a, d
- C. b, a, c, d
- D. c, a, b, d
28. Chế biến thực phẩm nhằm các mục đích sau đây, TRỪ:
- A. Giảm gánh nặng cho bộ máy tiêu hóa
- B. Tăng hấp thu các chất dinh dưỡng
- C. Bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể
- D. Loại trừ được các yếu tố độc hại
29. Bảo quản thực phẩm bằng phương pháp muối chua sẽ:
- A. Tiêu diệt được toàn bộ vi khuẩn
- B. Tiêu diệt được một số vi khuẩn
- C. Làm ngừng sự phát triển của toàn bộ vi khuẩn và trứng giun sán
- D. Tiêu diệt được một số vi khuẩn và trứng giun sán
30. Cách rửa rau sống tốt nhất là:
- A. Rửa ít nhất 2 lần trong thau nước rộng bằng nước sạch
- B. Rửa dưới vòi nước chảy một lần
- C. Rửa ít nhất 3 lần trong thau nước rộng bằng nước sạch

- D. Rửa ít nhất 4 lần trong thau nước rộng bằng nước sạch
31. Các yêu cầu cần phải thực hiện khi chế biến để giảm thiểu việc hao hụt các vitamin trong rau, nhất là vitamin C, TRỪ:
- A. Nấu chín tới và ăn ngay
 - B. Nấu chín, để nguội sau ít nhất 15 phút rồi mới ăn
 - C. Khi nấu chỉ nên cho rau vào nước đang sôi
 - D. Chi thái nhỏ trước khi cho rau vào nồi và không thái quá nhỏ,
32. Biện pháp chế biến đảm bảo giá trị dinh dưỡng của thực phẩm tốt nhất là:
- A. Ăn sống
 - B. Hấp, luộc
 - C. Rán
 - D. Quay

Hoà

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

1. Những chỉ số đánh giá tình trạng dinh dưỡng được sử dụng sau đây, chỉ số nào đánh giá suy dinh dưỡng cấp:
- A. Cân nặng theo tuổi (CN/T)
 - B. Chiều cao theo tuổi (CC/T)
 - C. Cân nặng theo chiều cao (CN/CC)
 - D. Chiều cao theo cân nặng (CC/CN)
2. Những chỉ số đánh giá tình trạng dinh dưỡng được sử dụng sau đây, chỉ số nào đánh giá suy dinh dưỡng mạn tính:
- A. Cân nặng theo tuổi (CN/T)
 - B. Chiều cao theo tuổi (CC/T)
 - C. Chiều cao theo cân nặng (CC/CN)

D. Cân nặng theo chiều cao (CN/CC)

3. Những chỉ số đánh giá tình trạng dinh dưỡng được sử dụng sau đây, chỉ số nào là chỉ số nhập:

A. Cân nặng theo tuổi (CN/T)

B. Chiều cao theo tuổi (CC/T)

C. Cân nặng theo chiều cao (CN/CC)

D. Chiều cao theo cân nặng (CC/CN)

4. Những chỉ số đánh giá tình trạng dinh dưỡng được sử dụng sau đây, chỉ số nào là chỉ số đặc hiệu:

A. Cân nặng theo tuổi (CN/T)

B. Chiều cao theo tuổi (CC/T)

C. Cân nặng theo chiều cao (CN/CC)

D. Chiều cao theo cân nặng (CC/CN)

5. Một cháu bé sinh ngày 18/12/2002, ngày điều tra là 15/12/2003. Cho đến ngày điều tra trẻ được bao nhiêu THÁNG tuổi?

A. 11 tháng

B. 12 tháng

C. 13 tháng

D. 14 tháng

6. Một cháu bé sinh ngày 14 / 04 / 2001, ngày điều tra là 15 / 12 / 2003. Cho đến ngày điều tra trẻ được bao nhiêu TUỔI?

A. 0 tuổi

B. 1 tuổi

C. 2 tuổi

D. 3 tuổi

7. Một trẻ 12 tháng tuổi, Z-score của chỉ số Cân nặng theo tuổi: là -2,0; trẻ được phân vào loại nào sau đây:

A. Thừa cân

B. Bình thường

C. Suy dinh dưỡng thể thấp còi

D. Suy dinh dưỡng thể gầy còm

E. Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

8. Một trẻ 36 tháng tuổi, Z-score của chỉ số Cân nặng theo chiều cao là $-3,5$; trẻ được phân vào loại nào sau đây:

- A. Bình thường
- B. Suy dinh dưỡng thể thấp còi
- C. Suy dinh dưỡng thể gầy còm
- D. Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

9. Một trẻ 24 tháng tuổi, Z-score của chỉ số Chiều cao theo tuổi là $-2,8$; trẻ được phân vào loại nào sau đây:

- A. Bình thường
- B. Suy dinh dưỡng thể thấp còi
- C. Suy dinh dưỡng thể gầy còm
- D. Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

10. Z-score của chỉ số Chiều cao theo tuổi một trẻ 45 tháng tuổi là $-2,0$, trẻ được phân vào loại nào sau đây:

- A. Bình thường
- B. Suy dinh dưỡng thể thấp còi
- C. Suy dinh dưỡng thể gầy còm
- D. Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

11. Một trẻ 48 tháng tuổi, Z-score của chỉ số Cân nặng theo chiều cao: là $+2,6$, trẻ được phân vào loại nào sau đây:

- A. Thừa cân
- B. Bình thường
- C. Suy dinh dưỡng thể thấp còi
- D. Suy dinh dưỡng thể gầy còm

12. Tính chỉ số khối cơ thể của một người trưởng thành theo công thức sau:

- A. Cân nặng (kg) \ chiều cao (m)
- B. Cân nặng (kg) \ chiều cao² (m)
- C. Cân nặng (g) / chiều cao² (cm)
- D. Cân nặng (kg) / chiều cao² (cm)

13. Một phụ nữ 25 tuổi (không có thai và không cho con bú), Chỉ số khối cơ thể (BMI) là 22,5. Tình trạng dinh dưỡng của người phụ nữ này thuộc loại nào?

A. Thừa cân

B. Bình thường

C. Thiếu năng lượng trường diễn độ 1

D. Thiếu năng lượng trường diễn độ 2

14. Một người đàn ông 30 tuổi, Chỉ số khối cơ thể (BMI) là 25,5. Tình trạng dinh dưỡng của người đàn ông này thuộc loại nào?

A. Thừa cân

B. Bình thường

C. Thiếu năng lượng trường diễn độ 1

D. Thiếu năng lượng trường diễn độ 2

15. Một sinh viên nam 18 tuổi, chỉ số khối cơ thể (BMI) là 17,5. Tình trạng dinh dưỡng của người sinh viên này thuộc loại nào?

A. Thừa cân

B. Bình thường

C. Thiếu năng lượng trường diễn độ 1

D. Thiếu năng lượng trường diễn độ 2

16. Một sinh viên nam 20 tuổi, Chỉ số khối cơ thể (BMI) là 16,5. Tình trạng dinh dưỡng của người sinh viên này thuộc loại nào?

A. Thừa cân

B. Bình thường

C. Thiếu năng lượng trường diễn độ 1

D. Thiếu năng lượng trường diễn độ 2

17. Tại một địa phương có tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi thể gầy còm là 10%, cộng đồng đó được đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở mức nào sau đây: [REDACTED]

A. Mức độ thấp

B. Mức trung bình

C. Mức độ cao

D. Mức độ rất cao

18. Tại một địa phương có tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân là 10 %, cộng đồng đó được đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở mức nào sau đây

A. Mức độ thấp

B. Mức trung bình

C. Mức độ cao

D. Mức độ rất cao

19. Tại một địa phương có tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi là 10 %, cộng đồng đó được đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở mức nào sau đây:

A. Mức độ thấp

B. Mức trung bình

C. Mức độ cao

D. Mức độ rất cao

20. Tại một địa phương có tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi thể gầy còm là 15%, cộng đồng đó được đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở mức nào sau đây:

A. Mức độ thấp

B. Mức trung bình

C. Mức độ cao

D. Mức độ rất cao

30% cao

21. Tại một địa phương có tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới [redacted] cộng đồng đó được đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở mức nào sau đây:

A. Mức độ thấp

[redacted]

C. Mức độ cao

D. Mức độ rất cao

22. Tại một địa phương có tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi thể [redacted] cộng đồng đó được đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở mức nào sau đây:

[redacted]

B. Mức trung bình

C. Mức độ cao

D. Mức độ rất cao

23. Tại một địa phương có tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi thể gầy còm là 30%, cộng đồng đó được đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở mức nào sau đây:

A. Mức độ thấp

B. Mức trung bình

C. Mức độ cao

D. Mức độ rất cao

24. Tại một địa phương có tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân là 30 %, cộng đồng đó được đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở mức nào sau đây:

A. Mức độ thấp

B. Mức trung bình

C. Mức độ cao

D. Mức độ rất cao

25. Tại một địa phương có tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ thấp còi là 30 %, cộng đồng đó được đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở mức nào sau đây:

A. Mức độ thấp

B. Mức trung bình

C. Mức độ cao

D. Mức độ rất cao

26. Đánh giá TTDD bằng chỉ số khối cơ thể có thể áp dụng cho các đối tượng sau đây:

A. Phụ nữ có thai

B. Phụ nữ cho con bú

C. Cụ già trên 60 tuổi.

D. Người 18-60 tuổi

27. Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ($BMI < 18,5$) của phụ nữ một xã là 10%, Đánh giá tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ở xã đó vào mức nào sau đây:

A. Mức thấp

B. Mức trung bình

C. Mức cao

D. Mức rất cao

28. Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ($BMI < 18,5$) của phụ nữ một xã là 19%, Đánh giá tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ở xã đó vào mức nào sau đây:

A. Mức thấp

B. Mức trung bình

C. Mức cao

D. Mức rất cao

29. Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ($BMI < 18,5$) của một khối sinh viên Y2 là 20%, Đánh giá tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ở đối tượng đó vào mức nào sau đây:

A. Mức thấp

B. Mức trung bình

C. Mức cao

D. Mức rất cao

30. Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ($BMI < 18,5$) của nữ nông dân ở xã X là 40%, Đánh giá tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ở đối tượng đó vào mức nào sau đây:

A. Mức thấp

B. Mức trung bình

C. Mức cao

D. Mức rất cao

31. Ngưỡng được coi là béo bụng theo Tỷ số vòng eo / vòng hông của một người đàn ông 45 tuổi là :

A. 0,75

B. 0,85

C. 0,90

D. 0,95

32. Ngưỡng được coi là béo bụng theo Tỷ số vòng eo/ vòng hông của một người phụ nữ 45 tuổi là:

A. 0,75

B. 0,85

C. 0,90

D. 0,95

33. Đặc điểm của phương pháp Đ giá tình trạng ddưỡng bằng phương pháp nhân trắc là:

A. Xác định được những thiếu hụt dinh dưỡng đặc hiệu

B. Trang thiết bị đắt, mang vác rất nặng.

B. Cán bộ phải có trình độ cao.

D. Đơn giản, an toàn và có thể điều tra được trên diện rộng

34. Ưu điểm của phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng phương pháp nhân trắc là:

A. Đánh giá được sự thay đổi nhỏ, trong thời gian ngắn.

B. Xác định được những thiếu hụt dinh dưỡng đặc hiệu.

C. Phân biệt được những rối loạn chuyển hoá / di truyền / nội tiết với thiếu hụt dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng.

D. Có thể đánh giá tình trạng dinh dưỡng trong quá khứ.

CÁC BỆNH DO THỰC PHẨM VÀ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

1. Loại thực phẩm dễ bị biến chất thành các sản phẩm độc như aldehyt, xeton gây nên ỉa chảy sau khi ăn là:

A. Rau

B. Quả

C. Thịt nạc

D. Dầu mỡ

2. Trong các vi khuẩn sau đây khi ô nhiễm vào thực phẩm, vi khuẩn có thể sinh độc tố trong thực phẩm là:

A. *C. botulinum*

B. *Salmonella*

C. *B. Cereus*

D. *S. aureus*

3. Trong tất cả các câu sau đây, câu nào là câu sai.

A. Vi khuẩn có thể có hại cũng có thể có ích

B. Tất cả các loại vi sinh vật đều có thể được sử dụng để bảo quản thực phẩm

- C. Có loại vi khuẩn có khả năng sản sinh ra acid lactic và các acid hữu cơ khác
- D. Có loại nấm mốc có lợi, có loại có hại
4. Nguy cơ nhiễm khuẩn đối với các loại gia vị là:
- A. *Bacillus cereus*
- B. *Salmonella*
- C. *Listeria monocytogenes*
- D. A và B đều đúng
5. Vi khuẩn gây bệnh thường thấy trong gạo là:
- A. *Salmonella*
- B. *Bacillus cereus*
- C. *Clostridium perfringens*
- D. *Listeria monocytogenes*
6. Thực phẩm có nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm do tụ cầu là:
- A. Thịt và các sản phẩm của thịt
- B. Cá và các sản phẩm của cá
- C. Các loại kẹo
- D. Các loại bánh có kem
7. Thực phẩm có nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm do *Salmonella* là:
- A. Thịt và các sản phẩm của thịt
- B. Cá và các sản phẩm của cá
- C. Các loại bánh kẹo
- D. Các loại bánh có kem
8. Thực phẩm có nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm do *Chostridium botulinum* là:
- A. Các loại thực phẩm hun khói
- B. Các loại thực phẩm lên men
- C. Các loại thực phẩm đóng hộp
- D. Các loại thực phẩm muối mặn
9. Aflatoxin là một độc tố được sinh ra do:
- A. *Fusarium graminearum*
- B. *Penicillium verrucosum*

C. *Asperillus flavus*

D. *Penicillium expansum*

10. Những biện pháp nấu nướng có thể làm phá huỷ được độc tố aflatoxin là:

A. Luộc

B. Rán

C. Hấp cách thuỷ

D. Hầm trong nồi hầm

11. Những tính chất sau đây là tính chất của độc tố do vi khuẩn *Clostridium botulinum* tiết ra trong thực phẩm, trừ:

A. Có tính độc rất cao, mạnh gấp 7 lần độc tố uốn ván

B. Chịu được các loại men tiêu hoá

C. Chịu được môi trường acid của dạ dày

D. Chịu được tác dụng bởi kiềm và nhiệt độ cao.

12. Nhiệt độ thích hợp tối ưu cho sự phát triển của *Aspegillus Flavus* là:

A. 25°C

B. 28°C

C. 32°C

D. 37°C

13. Thực phẩm ít bị ô nhiễm do vi sinh vật nhất là:

A. Sữa và chế phẩm của sữa

B. Đồ hộp và cá có dầu

C. Thịt và các sản phẩm của thịt

D. Các loại dầu ăn

14. Thời gian ủ bệnh của ngộ độc thức ăn do tụ cầu thường là:

A. 1- 6 giờ

B. 6- 12 giờ

C. 12 - 24 giờ

D. 24- 36 giờ

15. Triệu chứng lâm sàng thường gặp trong ngộ độc thực phẩm do tụ cầu, trừ:

- A. Nôn
- B. Sốt
- C. Tiêu chảy
- D. Đau bụng

16. Nhiệt độ thích hợp tối ưu cho sự phát triển của *Tụ cầu* là:

- A. $30^{\circ} - 35^{\circ}$
- B. $35^{\circ} - 37^{\circ}$
- C. $37^{\circ} - 40^{\circ}$
- D. $40^{\circ} - 42^{\circ}$

17. Thời gian ủ bệnh của ngộ độc thức ăn do *Salmonella* thường là:

- A. 1- 6 giờ
- B. 6- 12 giờ
- C. 12 - 24 giờ
- D. 24- 36 giờ

18. Triệu chứng lâm sàng Đặc hiệu trong trường hợp ngộ độc thực phẩm do *Salmonella* là:

- A. Nôn
- B. Sốt
- C. Tiêu chảy
- D. Đau bụng

19. Nhiệt độ thích hợp tối ưu cho sự phát triển của *Salmonella* là:

- A. $30^{\circ} - 35^{\circ}$
- B. $35^{\circ} - 37^{\circ}$
- C. $37^{\circ} - 40^{\circ}$
- D. $40^{\circ} - 42$

20. Đối tượng dễ nhạy cảm với ngộ độc thực phẩm do *Salmonella* là.

- A. Phụ nữ khỏe mạnh
- B. Người già và trẻ em bị suy dinh dưỡng
- C. Trẻ em lứa tuổi học đường
- D. Trẻ em dưới 5 tuổi khỏe mạnh

21. Biện pháp tốt nhất cho việc đề phòng ngộ độc thực phẩm do hoá chất bảo vệ thực vật là:

- A. Chọn rau quả cẩn thận khi mua
- B. Rửa rau quả sạch
- C. Người trồng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng loại, đúng liều và đủ thời gian cách li khi thu hoạch
- D. Tuyên truyền kiến thức cho người tiêu dùng

22. Đề phòng ngộ độc thực phẩm do *Salmonella* tốt nhất là:

- A. Khám tuyển và khám định kỳ cho công nhân phục vụ dịch vụ ăn uống
- B. Nâng cao sức khoẻ cho công nhân
- C. Rửa tay nhiều lần trước khi ăn
- D. Đun lại thức ăn trước khi ăn

23. Đề phòng ngộ độc do sắn bao gồm những biện pháp sau đây, trừ:

- A. Cắt bỏ 2 đầu củ sắn
- B. Bóc vỏ, ngâm kỹ trước khi luộc
- C. Phơi khô sắn
- D. Chọn củ sắn có vỏ đỏ sẫm

24. Những biện pháp nấu nướng có thể làm phá huỷ được độc tố aflatoxin là:

- A. Luộc
- B. Rán
- C. Hấp cách thuỷ
- D. Hầm trong nồi hầm

25. Nguyên nhân của thực phẩm bị ô nhiễm *Salmonella*, Trừ:

- A. Do động vật bị bệnh trước khi giết thịt
- B. Do ô nhiễm vi khuẩn từ dụng cụ vào thịt trong khi giết thịt
- C. Do thực phẩm nguội bị nhiễm trùng khi ăn không đun lại
- D. Do rửa thực phẩm không kỹ

26. Khoảng nhiệt độ nguy hiểm nhất trong bảo quản thực phẩm là:

- A. 0-5°C
- B. 10-15°C
- C. 10-30°C
- D. 10-60°C

27. Đề phòng ngộ độc thực phẩm do tụ cầu tốt nhất là:

- A. Khám tuyển và khám định kỳ cho công nhân phục vụ dịch vụ ăn uống
- B. Rửa tay nhiều lần trước khi ăn
- C. Đun lại thức ăn trước khi ăn
- D. Bảo quản thực phẩm theo đúng quy định

28. Đề phòng ngộ độc do cóc tốt nhất là:

- A. Chọn loại cóc không độc
- B. Quản lý và xử lý nghiêm ngặt với người buôn bán cóc
- C. Chế biến cóc không để chất độc dính vào thịt
- D. Không ăn thịt cóc

29. Đề phòng ngộ độc thực phẩm do cá nóc tốt nhất là:

- A. Chọn cá nóc không độc.
- B. Hầm cá nóc trong nồi hầm
- C. Ngâm cá nóc vào kiềm để loại bỏ chất độc
- D. Không ăn cá nóc.

30. Hậu quả của thực phẩm không an toàn là:

- A. Chỉ gây bệnh cấp tính
- B. Rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể
- C. Ảnh hưởng tới giống nòi
- D. Người tiêu dùng mất lòng tin

31. Các nguyên nhân gây ô nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm sau đây, TRỪ:

A. Môi trường bị ô nhiễm

B. Do thiếu vệ sinh trong quá trình chế biến

C. Do bản thân thực phẩm, gia súc, gia cầm đã bị bệnh

D. Thô nhiễm từ dụng cụ chế biến chứa đựng, bảo quản thực phẩm

32. Các nguyên nhân ô nhiễm hoá chất vào thực phẩm sau đây, TRỪ:

A. Môi trường bị ô nhiễm

B. Sử dụng hóa chất, phụ gia không đúng quy định

C. Thô nhiễm từ dụng cụ chế biến chứa đựng, bảo quản thực phẩm

D. Do bản thân thực phẩm, gia súc, gia cầm đã bị bệnh

TỔ CHỨC ĂN UỐNG TRONG BỆNH VIỆN VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĂN THƯỜNG GẶP

1. Chế độ ăn hạn chế protein chỉ định trong.

A. Xơ mỡ động mạch

B. Béo phì

C. Viêm thận mạn tính

D. Cao huyết áp

2. Bệnh nhân mắc bệnh loét dạ dày tá tràng được chỉ định chế độ ăn sau.

A. Hạn chế gluxit (giảm bột, đường)

B. Chế độ ăn bồi dưỡng.

C. Hạn chế xơ (Kích thích cơ học) và các chất kích thích hoá học

D. Hạn chế xơ và các chất lên men

3. Chế độ ăn hạn chế muối tương đối.

A. Được phép dùng cả muối

B. Cấm nấu thức ăn bằng muối

C. Không được dùng cá nước ngọt

D. Có thể dùng được nước mắm

4. Chế độ ăn hạn chế muối tuyệt đối là.

A. Cơm + quả + đường (Kempner)

B. Dầu + đường (Borat- Bull)

C. Cơm + trứng + quả

D. Cơm + khoai + quả (Ăn chay)

5. Chỉ định chế độ ăn tăng protein trong:

A. Hội chứng u rê máu cao tất cả các loại

B. Xơ cứng động mạch

C. Hội chứng thận hư

D. Viêm thận cấp

6. Chế độ ăn hạn chế lipid được chỉ định khi.

A. Thận hư nhiễm mỡ

B. Viêm túi mật

C. Suy thận

D. Phụ nữ có thai 3-6 tuần lễ cuối

7. Chế độ ăn hạn chế năng lượng chỉ định trong:

A. Đái đường

- B. Gout
 - C. Sau phẫu thuật
 - D. Bệnh gan – mật
8. Bệnh Gout cần cho chế độ ăn.
- A. Hạn chế lipid
 - B. Hạn chế Kali
 - C. Hạn chế Purin
 - D. Hạn chế muối NaCl
9. Khái niệm “Đậm độ năng lượng” là số năng lượng sinh ra tính theo đơn vị:
- A. Thể tích thức ăn
 - B. Trọng lượng cơ thể
 - C. Diện tích da
 - D. Thể tích hoặc đơn vị trọng lượng thức ăn
10. Đậm độ dinh dưỡng là .
- A. Tổng năng lượng của khẩu phần
 - B. Số lượng các chất dinh dưỡng cần thiết của cả khẩu phần
 - C. Số lượng các chất dinh dưỡng cần thiết được tính theo đơn vị năng lượng
 - D. Số lượng các chất dinh dưỡng cần thiết được tính trung bình 1 ngày cho 1 cá thể
11. Khái niệm “calori rỗng” dùng để chỉ thức ăn có đậm độ:
- A. Năng lượng cao
 - B. Dinh dưỡng thấp
 - C. Năng lượng cao nhưng đậm độ dinh dưỡng thấp.
 - D. Năng lượng thấp nhưng đậm độ dinh dưỡng cao.
12. Chế độ ăn uống là một thuật ngữ để chỉ
- A. Một khẩu phần ăn hàng ngày với các thực phẩm khác nhau.
 - B. Khẩu phần ăn đã được cải tiến cho mục đích điều trị
 - C. Một khẩu phần ăn hàng ngày với các thực phẩm khác nhau hoặc khẩu phần ăn đã được cải tiến cho mục đích điều trị bệnh
 - D. Một khẩu phần ăn kiêng.

13. Khái niệm “Dinh dưỡng hỗ trợ” dùng để chỉ cách nuôi dưỡng bệnh nhân qua:

- A. Đường miệng và ống thông
- B. Ống thông và đường tĩnh mạch
- C. Đường miệng, ống thông và đường tĩnh mạch
- D. Đường miệng và đường tĩnh mạch.

14. Nuôi dưỡng bệnh nhân qua đường miệng là.

- A. Cách đưa thức ăn thông thường qua đường miệng
- B. Cách đưa thức ăn thông thường qua đường ống thông
- C. Cách đưa thức ăn qua cả hai đường trên trong mọi trường hợp
- D. Cách đưa thức ăn thông thường qua đường miệng và qua đường ống thông khi thức ăn không đưa qua được đường miệng

15. Nuôi dưỡng bằng ống thông là:

- A. Cách nuôi dưỡng bổ sung nuôi ăn đường tĩnh mạch.
- B. Cách nuôi dưỡng thay thế nuôi ăn đường tĩnh mạch.
- C. Cách nuôi dưỡng bổ sung hoặc thay thế nuôi ăn qua đường miệng khi lượng thức ăn ăn vào của bệnh nhân quá cao.
- D. Cách nuôi dưỡng bổ sung hoặc thay thế nuôi ăn qua đường miệng khi lượng thức ăn ăn vào của bệnh nhân quá thấp.

16. Men tiêu hoá có tác dụng trong dinh dưỡng điều trị.

- A. Làm tăng hiệu suất chuyển hoá và tăng đậm độ chất dinh dưỡng
- B. Làm tăng đậm độ chất dinh dưỡng và giảm độ quánh thức ăn
- C. Làm tăng hiệu suất chuyển hoá và giảm độ quánh thức ăn
- D. Làm tăng hiệu suất chuyển hoá, tăng đậm độ chất dinh dưỡng và giảm độ quánh thức ăn

17. Men tiêu hoá có tác dụng chuyển hoá các chất:

- A. Bột, đạm và béo
- B. Bột và đạm

C. Đạm và Vitamin

D. Béo và Vitamin

18. Đánh giá tình trạng dự trữ lipid (dự trữ mỡ) của bệnh nhân, dùng số đo sau.

A. Vòng hông

B. Bề dày nếp gấp da

C. Chiều cao

D. Vòng bụng

19. Tình trạng giảm dự trữ lipid của bệnh nhân được đánh giá khi.

A. Trung bình nếp gấp da cơ tam đầu dưới 40 % so với chuẩn

B. Trung bình nếp gấp da cơ tam đầu dưới 4 % so với chuẩn

C. Trung bình nếp gấp da cơ tam đầu dưới 60 % so với chuẩn

D. Trung bình nếp gấp da cơ tam đầu dưới 6 % so với chuẩn

20. Nguyên tắc thay thế thực phẩm có nghĩa là.

A. Khi thay thế thực phẩm cần tính lượng tương đương để cho giá trị dinh dưỡng của khẩu phần không bị thay đổi.

B. Khi thay thế thực phẩm cần phải tính số lượng tương đương

C. Khi thay thế thực phẩm cần phải tính giá trị năng lượng tương đương

D. Khi thay thế thực phẩm cần tính số lượng protein tương đương.

21. Chế độ ăn toan là chế độ ăn bao gồm các thức ăn

A. Có nguồn gốc động vật + ngũ cốc + dầu + mỡ.

B. Có nguồn gốc thực vật (trừ ngũ cốc) + dầu + mỡ.

C. Có nguồn gốc động vật (trừ sữa và tiết) + ngũ cốc + dầu + mỡ.

D. Sữa + rau quả

22. Chế độ ăn kiềm là chế độ ăn bao gồm các thức ăn

A. Có nguồn gốc động vật + ngũ cốc + dầu + mỡ.

B. Sữa + rau quả

C. Có nguồn gốc động vật (trừ sữa và tiết) + ngũ cốc + dầu + mỡ.

D. Có nguồn gốc thực vật (trừ ngũ cốc) + dầu + mỡ.

23. Đối với bệnh nhân sau mổ dạ dày cần truyền dịch:

- A. Nên truyền dịch trong khi ăn
- B. Nên truyền dịch trước khi ăn 30-60 phút
- C. Nên truyền dịch sau khi ăn 30-60 phút
- D. Nên truyền dịch sau khi ăn 60-120 phút

24. Chế độ ăn hạn chế kali được chỉ định trong trường hợp sau:

- A. Bệnh tim mạch + Tăng huyết áp
- B. Suy thận giai đoạn cuối + Lọc máu nhân tạo
- C. Viêm cầu thận + suy gan
- D. Thận hư nhiễm mỡ

25. Lượng nước uống hàng ngày cần cho bệnh nhân là

- A. 1000 ml - 2000 ml
- B. 150 ml – 2500 ml
- C. 1500 ml – 2500 ml
- D. 1200 ml – 2500 ml

26. Để tránh các tác động cơ học từ thức ăn, cần chú ý:

- A. Hạn chế hoặc loại trừ các thức ăn dạng lỏng.
- B. Hạn chế hoặc loại trừ các thức ăn thô, các thực phẩm khó tiêu chứa nhiều cellulose.
- C. Hạn chế hoặc loại trừ các thức ăn chế biến sẵn.
- D. Hạn chế hoặc loại trừ các thức ăn cho nhiều gia vị.

27. Để tránh các tác động hóa học từ thức ăn, khi chế biến nên:

- A. Loại trừ các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và hạn chế các món ăn rán.
- B. Hạn chế hoặc loại trừ các thức ăn thô, các thực phẩm khó tiêu chứa nhiều cellulose.
- C. Loại trừ các thực phẩm giàu chất chiết xuất và hạn chế các món ăn gây kích thích tiết dịch vị của dạ dày và ruột.
- D. Loại trừ các thực phẩm giàu chất chiết xuất và hạn chế các món ăn luộc hay nấu.

28. Cơ sở của việc đưa ra các nguyên tắc ăn uống cho người bệnh

- A. Dựa vào chẩn đoán xác định là bệnh gì
- B. Dựa vào mức độ nặng - nhẹ của bệnh
- C. Dựa vào khả năng tiếp nhận thức ăn của bệnh nhân

D. Dựa vào mức độ của bệnh và khả năng tiếp nhận thức ăn của bệnh nhân.

29. Trong quá trình nuôi dưỡng bệnh nhân nặng, khẩu phần ăn cần chú ý

- A. Đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết
- B. Đủ năng lượng và các chất điện giải
- C. Đủ năng lượng + đủ nước

D. Đủ năng lượng + các chất dinh dưỡng cần thiết + nước + các chất điện giải

30. Nhiệm vụ của khoa dinh dưỡng

- A. Phục vụ chế độ ăn cho bệnh nhân, nhân viên bệnh viện và nghiên cứu khoa học.
- B. Tham vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân và nghiên cứu khoa học
- C. Phục vụ chế độ ăn cho bệnh nhân, nhân viên bệnh viện, thực hiện tham vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân và công tác nghiên cứu khoa học.
- D. Phục vụ chế độ ăn cho bệnh nhân, nhân viên bệnh viện và tham vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân.

31. Trong dinh dưỡng điều trị người ta sử dụng rộng rãi các nguyên tắc

- A. Hạn chế về số lượng
- B. Hạn chế về số lượng và chất lượng
- C. Tăng cường về số lượng
- D. Tăng cường về số lượng và chất lượng

32. Thời gian tư vấn dinh dưỡng phù hợp nhất cho bệnh nhân

- A. Khi bệnh nhân ra viện
- B. Bất kể lúc nào trong suốt quá trình nằm viện
- C. Ngay sau khi nhập viện
- D. Trong thời gian nhân viên y tế thăm bệnh nhân hoặc điều trị tại buồng bệnh

CHẾ ĐỘ ĂN ĐIỀU TRỊ TRONG MỘT SỐ BỆNH

1. Nguy cơ tăng huyết áp thường gặp ở nam giới uống rượu với số lần

A. 1-3 lần/ngày

B. 3-5 lần/ngày

C. 5-7 lần/ngày

D. 7-9 lần/ngày

2. Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn điều trị tăng huyết áp cần tuân thủ hạn chế muối natri ở dưới mức :

A. 66 gam/ngày

B. 60 gam/ngày

C. 16 gam/ngày

D. 6 gam/ngày

3. Lượng đạm cần thiết trong chế độ ăn người tăng huyết áp nên là.

A. 0,4 – 0,6 g / kg thể trọng / ngày

B. 0,6 – 0,8 g / kg thể trọng / ngày

C. 0,8 – 1,0 g / kg thể trọng / ngày

D. 1,0 – 1,2 g / kg thể trọng / ngày

4. Những thức ăn và đồ uống nào sau đây nên dùng cho bệnh nhân tăng huyết áp

A. Có tác dụng an thần và lợi tiểu

B. Có tác dụng lợi tiểu và hạ huyết áp

C. Có tác dụng an thần và hạ huyết áp

D. Có tác dụng an thần, lợi tiểu và hạ huyết áp.

5. Nguyên nhân của bệnh đái đường là do.

A. Rối loạn chuyển hóa glucid

B. Rối loạn chuyển hóa lipid

C. Rối loạn chuyển hóa protid

D. Rối loạn chuyển hóa glucid, lipid và protid

6. Tỷ lệ % năng lượng của các bữa phụ cho bệnh nhân đái đường là .

A. 40 % tổng năng lượng cả ngày

B. 30 % tổng năng lượng cả ngày

C. 20 % tổng năng lượng cả ngày

D. 10 % tổng năng lượng cả ngày

7. Số gam Protein dùng cho bệnh nhân đái đường người lớn nên là.

A. 18 gam / kg thể trọng/ ngày

B. 8 gam / kg thể trọng/ ngày

C. 0,8 gam / kg thể trọng/ ngày

D. 0,88 gam / kg thể trọng/ ngày

8. Đối với bệnh nhân đái đường chỉ nên ăn tối đa bánh mì bao nhiêu lần trong 1 ngày ?

A. 4 lần / ngày

B. 3 lần / ngày

C. 2 lần / ngày

D. 1 lần / ngày

9. Nuôi trẻ trong thời gian phục hồi suy dinh dưỡng đối với trẻ còn bú nếu người mẹ có sữa như thế nào ?

A. Cai sữa

B. Bú mẹ đến 12 tháng

C. Bú mẹ đến 18 tháng

D. Bú mẹ đến 24 tháng

10. Để phục hồi trẻ suy dinh dưỡng nặng nên sử dụng thức ăn có đậm độ năng lượng cao:

A. 4 kcal / 1 ml thức ăn

B. 14 kcal / 1 ml thức ăn

C. 11 kcal / 1 ml thức ăn

D. 1kcal / 1 ml thức ăn

11. Khi phục hồi trẻ suy dinh dưỡng thể vừa và nhẹ ở lứa tuổi đã ăn được thức ăn bổ sung nên cho ăn thêm quả chín trong 1 ngày:

A. 1-2 lần

B. 2-3 lần

C. 3-4 lần

D. 4-5 lần

12. Nguyên tắc đầu tiên khi xây dựng chế độ ăn cho bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng là :

A. Sử dụng thức ăn mềm và nhiệt độ thức ăn thích hợp là 40-50 ° C

B. Không dùng thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh

C. Sử dụng thức ăn mềm và không nên ăn thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh

D. Sử dụng thức ăn mềm, nhiệt độ thức ăn thích hợp là 40-50 ° C và không dùng thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh

13. Đối với bệnh nhân loét dạ dày tá tràng giai đoạn ngoài cơn đau được chỉ định chế độ ăn :

- A. Sữa đơn thuần
 - B. Hạn chế
 - C. Rộng rãi
 - D. Kiên cố chặt chẽ
14. Nguyên tắc đầu tiên xây dựng chế độ ăn cho bệnh nhân tăng huyết áp.
- A. Ít Natri và giàu kali
 - B. Ít Natri và giàu canxi
 - C. Ít Natri và ít magie
 - D. Ít Natri, giàu kali, giàu canxi và magie.
15. Mục đích xây dựng chế độ ăn cho bệnh nhân đái đường là:
- A. Duy trì tình trạng dinh dưỡng và cân bằng chuyển hoá
 - B. Duy trì cân bằng chuyển hoá và ngăn ngừa các biến chứng
 - C. Duy trì tình trạng dinh dưỡng và ngăn ngừa các biến chứng
 - D. Duy trì tình trạng dinh dưỡng, cân bằng chuyển hoá và ngăn ngừa các biến chứng
16. Số lần cho bệnh nhân đái đường ăn quả ngọt trong 1 ngày là:
- A. Tập trung ăn cùng một lúc.
 - B. 2-3 lần
 - C. 3-4 lần
 - D. 4-5 lần
17. Trẻ đang bú mẹ mắc suy dinh dưỡng thường do.
- A. Trẻ bú mẹ không đủ số lượng và sữa mẹ kém chất lượng
 - B. Mẹ thiếu và mất sữa
 - C. Sai lầm của người mẹ trong phương pháp nuôi dưỡng trẻ.
 - D. Sai lầm về phương pháp nuôi dưỡng nhất là khi mẹ thiếu và mất sữa.
18. Suy dinh dưỡng trong bệnh viện thường gặp ở bệnh nhân có tình trạng.
- A. Thiếu hụt protein
 - B. Thiếu hụt năng lượng
 - C. Thiếu hụt cả protein và năng lượng
 - D. Thiếu hụt protein, năng lượng và giảm dự trữ mỡ

19. Nhân tố làm tăng nguy cơ bệnh viêm loét dạ dày tá tràng là:

- A. Quá căng thẳng về thần kinh tâm lý
- B. Tính chất thức ăn không phù hợp
- C. Mức độ lao động quá nặng
- D. Tình trạng căng thẳng thần kinh và tính chất thức ăn không phù hợp

20. Khi tính năng lượng khẩu phần cho bệnh nhân đái đường điều trị nội trú tại bệnh viện, số calo nên là:

- A. < 5 Kcalo /kg/ngày
- B. < 15 Kcalo /kg/ngày
- C. < 25 Kcalo /kg/ngày
- D. < 35 Kcalo /kg/ngày

21. Loại quả có chỉ số đường huyết thấp dùng tốt cho người bệnh bị đái đường là:

- A. Mít mật
- B. Na
- C. Dưa hấu
- D. Chuối tiêu

22. Nguyên tắc đầu tiên khi xây dựng chế độ ăn cho bệnh nhân đái đường thể không phụ thuộc vào insulin (týp II) và thể phụ thuộc vào insulin (týp I nhẹ).

- A. Đảm bảo đủ năng lượng
- B. Giảm bớt năng lượng
- C. Cân bằng giữa các yếu tố sinh năng lượng.
- D. Đối với người không béo đảm bảo đủ năng lượng để giữ cân nặng bình thường. Đối với người béo cần giảm bớt năng lượng.

23. Thực phẩm cấm dùng cho bệnh nhân đái đường là:

- A. Gạo
- B. Bánh mì
- C. Mứt

D. Sữa

24. Lương thực có chỉ số đường huyết thấp dùng tốt cho bệnh nhân đái đường :

A. Mỳ sợi

B. Bánh mỳ

C. Gạo giã rối

D. Gạo giã trắng

25. Tỷ lệ % năng lượng do glucid cung cấp trong khẩu phần của bệnh đái đường nên là:

A. 30 - 40

B. 40 - 50

C. 50 - 60

D. 60 - 70

26. Nguyên tắc cơ bản của chế độ ăn cho bệnh viêm loét dạ dày tá tràng.

A. Cung cấp thức ăn giàu đạm + giàu mỡ + giàu đường.

B. Sử dụng thức ăn mềm + Ăn no + Ăn thêm bữa phụ ban đêm.

C. Kiên gia vị + Không ăn thức ăn chua + Cấm uống rượu.

D. Sử dụng thức ăn mềm + Sử dụng thức ăn giảm tiết dịch vị + thức ăn ở nhiệt độ thích hợp.

27. Chế biến các món ăn cho bệnh viêm loét dạ dày tá tràng cần chú ý.

A. Thực phẩm nên nghiền kĩ hoặc thái nhỏ.

B. Thực phẩm nên nghiền kĩ hoặc thái nhỏ và sử dụng khi thức ăn ở nhiệt độ 40-50 ° C.

C. Chế biến thức ăn ở dạng không đặc quá hay loãng quá.

D. Chế biến thức ăn ở dạng không đặc quá hay loãng quá và sử dụng khi thức ăn ở nhiệt độ 40-50 ° C.

28. Thức ăn sau khi chế biến dùng tốt nhất cho bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng là:

A. Rất đặc.

B. Không quá đặc.

C. Không quá loãng.

D. Không quá đặc hoặc không quá loãng.

29. Nên khuyên cho bệnh nhân loét dạ dày tá tràng :

A. Ăn vừa phải vào các bữa chính

- B. Chỉ ăn các bữa phụ là đủ
- C. Ăn thật no các bữa chính và thêm 1 bữa phụ
- D. Ăn vừa phải bữa chính và ăn thêm bữa phụ vào lúc 10h, 15h và 21h
30. Yếu tố tinh thần cần quan tâm khi hướng dẫn chế độ ăn cho bệnh nhân loét dạ dày tá tràng là:
- A. Sinh hoạt thoải mái và làm việc điều độ
- B. Làm việc điều độ và tránh căng thẳng về tinh thần.
- C. Sinh hoạt thoải mái và tránh căng thẳng về tinh thần
- D. Sinh hoạt thoải mái, làm việc điều độ và tránh căng thẳng về tinh thần.
31. Đối với trẻ em đang trong thời kỳ bú mẹ bị viêm loét dạ dày tá tràng nên:
- A. Ngừng cho trẻ bú
- B. Cho trẻ bú ít bữa đi
- C. Cho trẻ bú nhiều lần
- D. Cho trẻ bú theo giờ nhất định.
32. Chế độ ăn kiêng ít của bệnh loét dạ dày tá tràng có thể dùng trong trường hợp :
- A. Hội chứng gan mật
- B. Hội chứng thận hư
- C. Hội chứng rối loạn tiêu hoá
- D. Bệnh nhân trước mổ đường tiêu hóa.

DINH DƯỠNG DỰ PHÒNG CÁC BỆNH RĂNG MIỆNG

1. Các bệnh răng miệng có liên quan đến:

- A. Ăn nhiều đường
- B. Ăn ít chất xơ
- C. Ăn nhiều đường và ít chất xơ
- D. Ăn nhiều đường và nhiều chất xơ

2. Vi khuẩn tạo ra acid làm tổn thương men răng khi sử dụng:

- A. Thức ăn ngọt
- B. Đồ uống ngọt
- C. Nước Soda
- D. Thức ăn ngọt và đồ uống ngọt

3. Phòng sâu răng do ăn uống bằng cách làm răng sạch:

- A. Ít nhất 4 lần/ngày
- B. Ít nhất 3 lần/ngày
- C. Ít nhất 2 lần/ngày
- D. Ít nhất 1 lần/ngày

4. Để tránh các bệnh về răng do ăn uống không đúng cách gây nên, khi sử dụng thức ăn ngọt và thức ăn giàu chất xơ bạn cần phải.

- A. Ăn thức ăn giàu chất xơ trước rồi ăn thức ăn ngọt sau

- B. Ăn thức ăn ngọt trước rồi ăn thức ăn giàu chất xơ sau
 - C. Chỉ ăn một trong hai thức ăn trên
 - D. Ăn đồng thời cả thức ăn ngọt và thức ăn giàu chất xơ
5. Hậu quả sức khoẻ của các bệnh răng miệng có liên quan đến ăn uống là
- A. Tình trạng nhiễm trùng
 - B. Tình trạng biếng ăn
 - C. Tình trạng thiếu dinh dưỡng
 - D. Tình trạng rối loạn tiêu hoá.
6. Nguyên nhân dễ dẫn đến các bệnh quanh răng có liên quan đến ăn uống là:
- A. Ăn nhiều thức ăn dính
 - B. Uống nhiều nước ngọt
 - C. Ăn nhiều bánh ngọt
 - D. Vệ sinh răng miệng kém
7. Chất hoá học có thể phòng được các bệnh răng miệng có liên quan đến ăn uống là:
- A. Clorua
 - B. Florua
 - C. Fluor
 - D. Acid
8. Để tránh các bệnh răng miệng có liên quan đến ăn uống, trong khẩu phần ăn hàng ngày lượng đường tự do nên chiếm tỷ lệ.
- A. Trên 20 % tổng năng lượng khẩu phần
 - B. Trên 10 % tổng năng lượng khẩu phần
 - C. Không quá 10 % tổng năng lượng khẩu phần
 - D. Không quá 20 % tổng năng lượng khẩu phần
9. Để phòng các bệnh răng miệng có liên quan đến ăn uống, tần suất tiêu thụ các thực phẩm hoặc đồ uống có chứa các đường tự do cần được giới hạn ở mức
- A. Tối thiểu 4 lần/ 1 ngày
 - B. Tối thiểu 14 lần/ 1 ngày

C. Tối đa 4 lần/ 1 ngày

D. Tối đa 14 lần/ 1 ngày

10. Sự giảm sản men răng có liên quan đến các yếu tố dinh dưỡng:

A. Thiếu vitamin A và vitamin D

B. Thiếu protein và năng lượng

C. Thiếu protein, vitamin A và vitamin D

D. Thiếu protein, năng lượng, vitamin A và vitamin D

11. Loại nước có khả năng hạn chế được sâu răng là:

A. Nước Soda

B. Nước có chứa Fluor

C. Nước tinh khiết

D. Nước giải khát không đường

12. Thời gian vi khuẩn có khả năng nhân lên trong chất bẩn bám quanh răng là:

A. Trong vòng 1 giờ

B. Trong vòng 2 giờ

C. Trong vòng 10 giờ

D. Trong vòng 20 giờ

13. Bình quân đầu người tiêu thụ đường không quá bao nhiêu gam trong 1 ngày:

A. 30 gam

B. 40 gam

C. 50 gam

D. 60 gam

14. Lượng fluor thích hợp trong nước uống nên ở mức.

A. 0,1 – 0,7 mg /lít

B. 0,7 – 1,2 mg /lít

C. 1,2 – 1,7 mg /lít

D. 1,7 – 2,2 mg /lít

15. Làm sạch răng ít nhất :

A. 4 lần/ngày

B. 3 lần/ngày

C. 2 lần/ngày

D. 1 lần/ngày

16. Số lượng răng sâu được đánh giá bằng chỉ số

A. BMI

B. GOBIFFF

C. DMF

D. GMP

Phú

VAI TRÒ VÀ NHU CẦU CÁC CHẤT DINH DƯỠNG VÀ TÍNH CÂN ĐỐI KHẨU PHẦN.
DINH DƯỠNG HỢP LÝ.

1. Duy trì cân nặng cơ thể là sự phối hợp điều hòa phức tạp giữa:

- a. Chế độ ăn uống và lao động.
 - b. Năng lượng dự trữ và năng lượng tiêu hao.
 - c. Năng lượng ăn vào và năng lượng dự trữ.
 - ☒ d. Khẩu phần ăn vào, CHCB, và tiêu hao năng lượng.
2. Bất cứ sự sai lệch nào trong hệ thống điều hòa cân bằng năng lượng của cơ thể đều có thể dẫn tới:
- a. Thừa hoặc thiếu dinh dưỡng.
 - b. Ảnh hưởng đến sức khỏe.
 - ☒ c. Rối loạn thiếu/thừa dinh dưỡng và dẫn đến các bệnh khác.
 - d. Ảnh hưởng đến sự hấp thu các chất dinh dưỡng khác.
3. Nếu cân bằng năng lượng dương, cơ thể sẽ tăng đầu tiên là:
- a. Khối nạc.
 - ☒ b. Khối mỡ.
 - c. Cả khối nạc và khối mỡ.
 - d. Cả khối nạc, khối mỡ và dịch thể
4. Vai trò năng lượng là:
- a. Tái tạo các mô, chuyển hóa cơ bản, phát triển, hồi phục.
 - ☒ b. Tái tạo các mô, duy trì thân nhiệt, tăng trưởng và cho các hoạt động.
 - c. Tiêu hao cho chuyển hóa cơ bản, hoạt động thể lực, đáp ứng với các tác nhân bên ngoài (như: thực phẩm, lạnh, stress, và thuốc), sinh sản, phát triển, hồi phục.
 - d. Tiêu hao cho chuyển hóa cơ bản, hoạt động thể lực, tác dụng động lực của thức ăn, sinh sản, phát triển, hồi phục.
5. Dựa trên các kết quả thực nghiệm, năng lượng cho chuyển hóa cơ bản:
- ☒ a. Ở người trưởng thành nam: 1 Kcal/1kg cân nặng cơ thể/1 giờ;
nữ: 0,9 Kcal/1kg cân nặng cơ thể/1 giờ.
 - b. Ở người trưởng thành nam: 0,9 Kcal/1kg cân nặng cơ thể/1 giờ;
nữ: 1 Kcal/1kg cân nặng cơ thể/1 giờ.
 - c. Cho mọi đối tượng nam: 1 Kcal/1kg cân nặng cơ thể/1 giờ;
nữ: 0,9 Kcal/1kg cân nặng cơ thể/1 giờ.
 - d. Cho mọi đối tượng nam: 0,9 Kcal/1kg cân nặng cơ thể/1 giờ;
nữ: 1 Kcal/1kg cân nặng cơ thể/1 giờ.

6. Năng lượng cho hoạt động thể lực trung bình chiếm khoảng:

- a. 10-15% tổng nhu cầu năng lượng.
- ☒ b. 15-30% tổng nhu cầu năng lượng.
- c. 20-30% tổng nhu cầu năng lượng.
- d. 10-30% tổng nhu cầu năng lượng.

7. Năng lượng cho hoạt động thể lực là phần E tiêu hao thay đổi nhiều nhất, khi lao động nặng có thể tăng so với chuyển hóa lúc nghỉ:

- ☒ a. 10-15 lần.
- b. 15-30 lần.
- c. 20-30 lần.
- d. 10-30 lần.

8. Theo loại lao động, nhu cầu năng lượng cả ngày cho lao động nhẹ là:

- a. 1800 – 2000 Kcal.
- ☒ b. 2200 - 2400 Kcal.
- c. 2600 - 2800 Kcal.
- d. 3000 - 3200 Kcal.

9. Nhu cầu năng lượng cho trẻ em 6-8 tháng tuổi theo WHO/UNICEF (1998)

- a. 404 kcal/ngày
- b. 450 kcal/ngày
- c. 550 kcal/ngày
- ☒ d. 682 kcal/ngày

10. Nhu cầu năng lượng cho trẻ em 9-11 tháng tuổi theo WHO/UNICEF (1998)

- a. 550 kcal/ngày
- b. 682 kcal/ngày
- ☒ c. 830 kcal/ngày
- d. 930 kcal/ngày

11. Người ta khuyên ở những nước như Việt Nam, tính nhu cầu năng lượng cho trẻ em không nên tính theo cân nặng vì:

- a. Khó xác định cân nặng chính xác của trẻ.
- ☒ b. Trẻ thường có cân nặng thấp bởi tình trạng SDD.

c. Cách tính này phức tạp.

d. Vì cả 3 lý do trên.

12. Lượng năng lượng để tăng thể trọng là:

- ☒ a. Tăng 1 g thể trọng cần 6-8 kcal.
- b. Tăng 10 g thể trọng cần 6-8 kcal.
- c. Tăng 100 g thể trọng cần 60-80 kcal.
- d. Tăng 1 g thể trọng cần ăn thêm 6-8 kcal.

13. Năng lượng cần thiết liên quan đến tiếp nhận thức ăn dao động từ:

- ☒ a. 5-10% nhu cầu so với năng lượng CHCB.
- b. 10-15% nhu cầu so với năng lượng CHCB.
- c. 10-25% nhu cầu so với năng lượng CHCB.
- d. 2-25% nhu cầu so với năng lượng CHCB.

14. Năng lượng cần thiết liên quan đến tiếp nhận thức ăn giàu protid là:

- ☒ a. 40% so với năng lượng CHCB.
- b. 16% so với năng lượng CHCB.
- c. 10-15% so với năng lượng CHCB.
- d. 6% so với năng lượng CHCB.

15. Phụ nữ mang thai 6 tháng cuối cần cung cấp thêm năng lượng hàng ngày là:

- a. 300-500 Kcal.
- ☒ b. 300-350 Kcal.
- c. 300-550 Kcal.
- d. 500-550 Kcal.

16. Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối, nhu cầu canxi tăng so với lúc không có thai là:

- a. 0%
- b. 100%
- ☒ c. 50%
- d. 25%

17. Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối, nhu cầu kẽm tăng so với lúc không có thai là:

- ☒ a. 0%

b. 100%

c. 50%

d. 25%

18. Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối, nhu cầu vitamin A tăng so với lúc không có thai là:

a. 0%

b. 100%

c. 50%

d. 25%

19. Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối, nhu cầu vitamin D tăng so với lúc không có thai là:

a. 0%

b. 100%

c. 50%

d. 25%

20. Để tạo ra được 100 ml sữa, trung bình người mẹ cần có:

a. 65 Kcal.

b. 165 Kcal.

c. 85 Kcal.

d. 185 Kcal.

21. Sau khi sinh 3 tháng, người mẹ có thể tiết được một lượng sữa ổn định, trung bình hàng ngày là:

a. 500 ml.

b. 650 ml.

c. 750 ml.

d. 850 ml.

22. Phụ nữ cho con bú 6 tháng đầu cần cung cấp thêm năng lượng hàng ngày là:

a. 300-500 Kcal.

b. 300-350 Kcal.

c. 300-550 Kcal.

d. 500-550 Kcal.

23. Phụ nữ cho con bú, nhu cầu vitamin A tăng so với lúc bình thường là:

- a. 33%
- b. 100%
- c. 0%
- d. 58%

24. Phụ nữ cho con bú, nhu cầu sắt tăng so với lúc bình thường là:

- a. 33%
- b. 100%
- c. 0%
- d. 58%

25. Phụ nữ cho con bú, nhu cầu kẽm tăng so với lúc bình thường là:

- a. 33%
- b. 100%
- c. 0%
- d. 58%

26. Ở người trung niên 40-59 tuổi, người ta đã khuyên nên giảm đi 5% năng lượng so với bình thường khi:

- a. Mỗi 10 năm tuổi cao thêm.
- b. Mỗi 5 năm tuổi cao thêm.
- c. Mỗi 10 năm tuổi.
- d. Mỗi 5 năm tuổi.

27. Trong khẩu phần người Việt Nam, tỷ lệ % năng lượng giữa Protein:Lipid:Glucid nên tiến tới

- a. 12:18:70
- b. 14:18:68
- c. 14:20:66
- d. 12:12:76